AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 18 · PE · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

PEDIATRÍA GENERAL

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

70	22	3
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 3 · Materno - Infantil · complemento visual del Tomo 18

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 18 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 39

Índice por tipo de imagen 42

Soluciones de la autoevaluación 44

Signos con nombre propio 41

Autoevaluación 43

01 Crecimiento, Desarrollo & Vacunas PNI

18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría

01 Curva de peso para la edad (OMS) 4

18.2 Desarrollo Psicomotor

02 Hitos del desarrollo psicomotor 4

18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

03 Acople incorrecto vs correcto 5

04 Acople correcto 5

05 Succión efectiva 6

06 Mancha mongólica 6

07 Signo de Crowe 7

08 Vitíligo 7

18.26 Genética y Dismorfias

09 Facies del síndrome de Down 8

10 Manchas de Brushfield 8

11 Piel laxa de la nuca 9

12 Hipotonía en la suspensión ventral 9

18.28 Pediatría Psicosocial

13 Quemadura en calcetín 10

14 Quemadura en guante 10

15 Fracturas sugerentes de maltrato 11

16 Hemorragias retinianas en el niño sacudido 11

02 Respiratorio Pediátrico & Urgencias

18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO)

17 Dificultad respiratoria en la bronquiolitis 12

18 Bronquiolitis: hiperinsuflación 12

18.6 Laringitis Aguda Obstructiva / Croup

19 Signo del campanario 13

20 Epiglotis rojo cereza 13

21 Signo del pulgar 14

18.7 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica

22 Neumonía lobar 14

23 Neumonía redonda 15

24 Infiltrado intersticial 15

25 Consolidación con broncograma 16

18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea

26 Cuerpo extraño en el bronquio derecho 16

27 Desobstrucción en el lactante 17

28 Maniobra de Heimlich 17

18.23 Cardiología Pediátrica

29 Taquicardia supraventricular 18

30 Preexcitación (WPW) 18

31 Vegetaciones en la ecografía 19

32 ECG normal de un recién nacido 19

33 ECG normal de un niño de 3 años 20

18.24 Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes

34 Lesión esofágica grave por cáusticos 20

03 Infecciones, Exantemas & Digestivo Pediátrico

Índice por tema · continuación

18.10 Exantemas Infantiles
35 Exantema súbito 21
36 Eritema infeccioso: signo de la bofetada 21
37 Lengua en fresa blanca 22
38 Kawasaki: labios fisurados 22
39 Escarlatina 23
40 Rubéola congénita: cataratas 23
41 Manchas de Koplik 24

18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico
42 Signo del pliegue 24

18.12 Vómitos en el Lactante
43 Estenosis hipertrófica del píloro 25
44 Deposición en jalea de grosella 25
45 Imagen en diana 26
46 Doble burbuja 26
47 Doble burbuja neonatal 27
48 Invaginación: signo del menisco 27

18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría
49 Grados de reflujo vesicoureteral 28
50 Reflujo vesicoureteral de alto grado 28
51 DMSA con cicatriz cortical 29

18.25 Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico
52 Eccema en Wiskott-Aldrich 29

04 Neonatología & Sala de Partos

18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal
53 Compresiones torácicas neonatales 30
54 Atresia de coanas 30

18.16 Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal
55 Test de Capurro 31
56 Retinopatía del prematuro tratada 31

18.17 Ictericia Neonatal
57 Ictericia neonatal 32
58 Nomograma de Bhutani y zonas de Kramer 32

18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal
59 Enfermedad de membrana hialina 33
60 Taquipnea transitoria 33
61 Aspiración meconial 34

18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile
62 Hipotiroidismo congénito sin tratar 34
63 Zonas de punción del talón 35
64 Tarjeta de papel filtro 35

18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23)
65 Maniobra de Ortolani 36
66 Maniobra de Barlow 36
67 Ecografía de cadera (Graf) 37
68 Arnés de Pavlik 37
69 Displasia de cadera en la Rx 38
70 Rx de pelvis con líneas de referencia 38

01 TEMA 18.1 · EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO & ESTADO NUTRICIONAL EN PEDIATRÍA

ESQUEMA

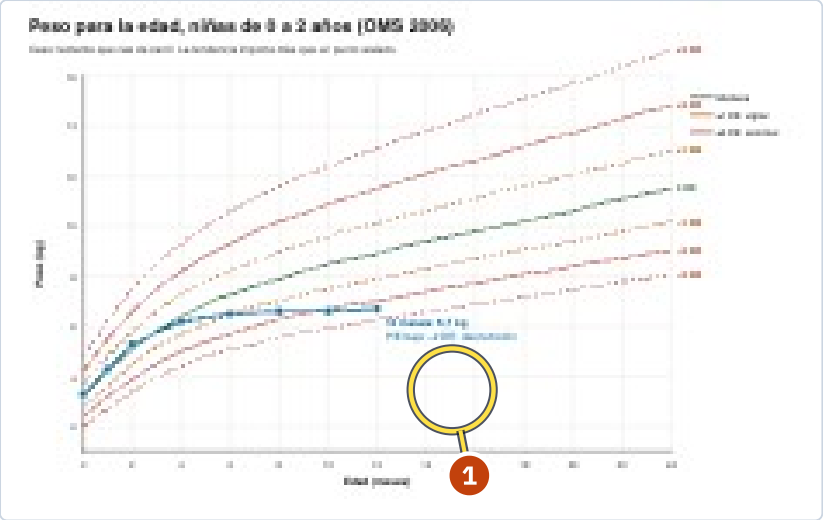


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Caída de carril

DIAGNÓSTICO

Curva de peso para la edad (OMS)

Lactante que cae de carril: importa la tendencia.

CONDUCTA INICIAL

P/E bajo −2 DE: desnutrición; buscar la causa.

2.01.3.003 **Diagnóstico nutricional** — examen/procedimiento

2.01.5.001 **Antropometría en la edad pediátrica** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Talla baja familiar: crece por su carril.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P72** «Un recién nacido de 10 días pesó 3.100 gramos al nacer. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y actualmente pesa 3.180 gramos. ¿Cuál es el…» → **Buen incremento ponderal**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 9** Tema 18.1

Clase 18.1 en video

02 TEMA 18.2 · DESARROLLO PSICOMOTOR

ESQUEMA

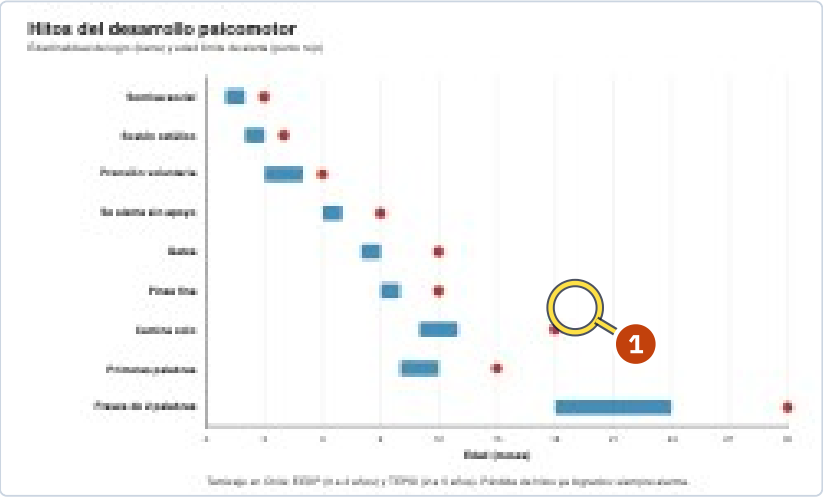


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Edad límite (punto rojo)

DIAGNÓSTICO

Hitos del desarrollo psicomotor

Edad habitual y edad límite de cada hito.

CONDUCTA INICIAL

Hito no logrado a la edad límite: alerta; EEDP o TEPSI.

2.01.3.002 **Desarrollo psico-motor** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Prematuro: corregir la edad.

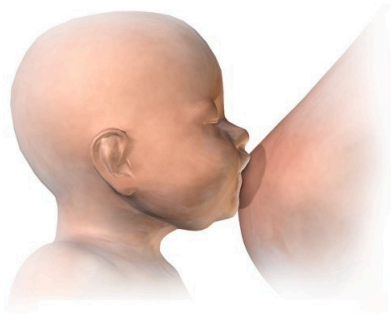
PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P46** «Madre consulta por evaluación de desarrollo de su hijo de 1 año y 3 meses. El niño camina solo, dice 3 palabras con significado y construye una…» → **Desarrollo normal para su edad**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 13** Tema 18.2

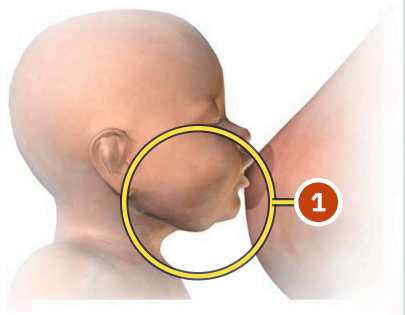
Clase 18.2 en video

03 TEMA 18.4 · LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA & SUPLEMENTACIÓN (VITAMINA D / FIERRO)

ESQUEMA



Acople incorrecto
(labio inferior hacia adentro)



Acople correcto

Imagen: Wikimedia Commons «Breastfeeding - Incorrect vs Correct Latch-On.png», CC BY-SA 4.0, BruceBlaus

QUÉ TIENES QUE VER

1 Acople correcto

DIAGNÓSTICO

Acople incorrecto vs correcto

Boca bien abierta, labio inferior evertido.

CONDUCTA INICIAL

Corregir la técnica antes de suplementar.

2.01.3.007 Lactancia materna — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Grietas del pezón por mal acople.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P99 «Usted atiende a un recién nacido de 10 días de vida, junto a su madre. Nació por parto vaginal sin complicaciones, pesando 3.200 gramos al nacer...» → **Reforzar la técnica de lactancia materna**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 20
Tema 18.4

Clase 18.4 en video

04 TEMA 18.4 · LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA & SUPLEMENTACIÓN (VITAMINA D / FIERRO)

FOTO CLÍNICA

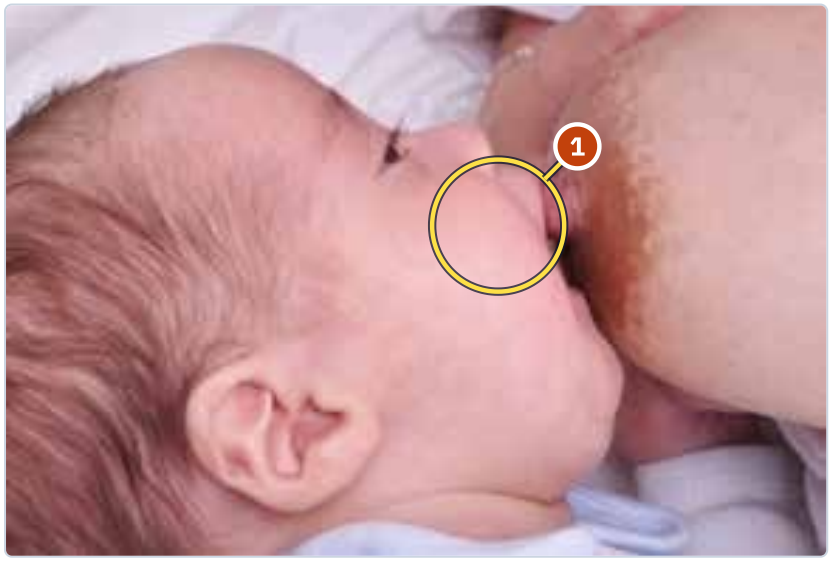


Imagen: Manual Operativo Lactancia MINSAL 2017, p. 13

QUÉ TIENES QUE VER

1 Boca sobre la areola

DIAGNÓSTICO

Acople correcto

Boca abierta que toma gran parte de la areola.

CONDUCTA INICIAL

Lactancia exclusiva hasta los 6 meses.

2.01.3.007 Lactancia materna — examen/procedimiento

3.01.3.004 Lactancia — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Succión del pezón solo.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P55 «Puérpera en su 10° día con PCR SARS-CoV-2 positivo y síntomas leves. ¿Cuál es la conducta respecto a la lactancia?» → **Mantener la lactancia con uso de mascarilla**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 20
Tema 18.4

Clase 18.4 en video

05 TEMA 18.4 · LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA & SUPLEMENTACIÓN (VITAMINA D / FIERRO)

ESQUEMA

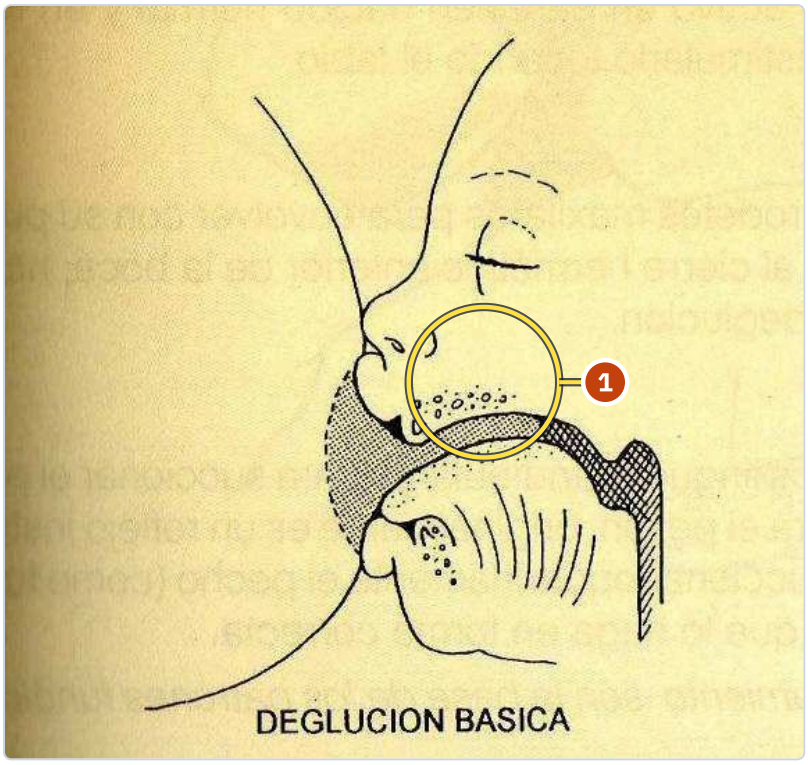


Imagen: Manual Lactancia Materna MINSAL 2010, p. 141

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lengua bajo el pezón

DIAGNÓSTICO

Succión efectiva

La lengua comprime el pezón contra el paladar.

CONDUCTA INICIAL

Observar una mamada en cada control.

2.01.3.007 **Lactancia materna**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Frenillo corto.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 20** Tema 18.4

Clase 18.4 en video

06 TEMA 18.4 · LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA & SUPLEMENTACIÓN (VITAMINA D / FIERRO)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5159 (Fig. 688.3)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mancha azul

DIAGNÓSTICO

Mancha mongólica

Mácula gris azulada en el dorso.

CONDUCTA INICIAL

Benigna; desaparece en la infancia.

2.01.1.105 **Alteraciones pigmentarias**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Equimosis por maltrato: cambia de color.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P3 «Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas…» → **Un componente de la dieta**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 19** Tema 18.4

Clase 18.4 en video

07 TEMA 18.4 · LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA & SUPLEMENTACIÓN (VITAMINA D / FIERRO)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4649 (Fig. 636.2)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pecas axilares

DIAGNÓSTICO

Signo de Crowe

Pecas axilares en la neurofibromatosis tipo 1.

CONDUCTA INICIAL

Criterios NF1: ≥ 6 manchas café con leche, pecas, neurofibromas.

2.01.1.105 Alteraciones pigmentarias — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.1.132 Dismorfias — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pecas solares: zonas expuestas.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P76 «Un niño de 14 años, con antecedente de su padre, que murió de muerte súbita, presenta talla alta, sus dedos y extremidades son muy largos y algo…» → **Síndrome de Marfán**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 19
Tema 18.4

Clase 18.4 en video

08 TEMA 18.4 · LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA & SUPLEMENTACIÓN (VITAMINA D / FIERRO)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5197 (Fig. 694.4)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mancha acrómica

DIAGNÓSTICO

Vitíligo

Manchas acrómicas simétricas de bordes netos.

CONDUCTA INICIAL

Corticoide o tacrolimus tópico.

2.01.1.105 Alteraciones pigmentarias — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pitiriasis alba: hipocrómica y descamativa.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 19
Tema 18.4

Clase 18.4 en video

09 TEMA 18.26 · GENÉTICA Y DISMORFIAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 57.5E

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fisuras oblicuas

DIAGNÓSTICO

Facies del síndrome de Down

Fisuras palpebrales oblicuas, epicanto y perfil plano.

CONDUCTA INICIAL

Ecocardiograma, TSH y control auditivo.

2.01.1.134 Trisomía 21

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipotiroidismo congénito.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 24** Tema 18.26

Clase 18.26 en video

10 TEMA 18.26 · GENÉTICA Y DISMORFIAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 57.5A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Manchas en el iris

DIAGNÓSTICO

Manchas de Brushfield

Puntos blancos en el iris.

CONDUCTA INICIAL

Signo del síndrome de Down.

2.01.1.134 Trisomía 21

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Iris normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 24** Tema 18.26

Clase 18.26 en video

11 TEMA 18.26 · GENÉTICA Y DISMORFIAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 57.5B

QUÉ TIENES QUE VER

1 Piel laxa

DIAGNÓSTICO

Piel laxa de la nuca

Exceso de piel en la nuca.

CONDUCTA INICIAL

Signo del síndrome de Down en el recién nacido.

2.01.1.134 Trisomía 21

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Higroma quístico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA p. 24 Tema 18.26

Clase 18.26 en video

12 TEMA 18.26 · GENÉTICA Y DISMORFIAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 57.5D

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tronco hipotónico

DIAGNÓSTICO

Hipotonía en la suspensión ventral

El recién nacido cae como un saco.

CONDUCTA INICIAL

Estudio con cariograma.

2.01.1.134 Trisomía 21

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipotonía de causa neuromuscular.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA p. 24 Tema 18.26

Clase 18.26 en video

13 TEMA 18.28 · PEDIATRÍA PSICOSOCIAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 17.2B

QUÉ TIENES QUE VER

1 Borde neto

DIAGNÓSTICO

Quemadura en calcetín

Bordes netos por inmersión.

CONDUCTA INICIAL

Sospecha de maltrato: denunciar.

2.01.1.138 **Maltrato infantil**

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Quemadura accidental: salpicadura.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 28** Tema 18.28

Clase 18.28 en video

14 TEMA 18.28 · PEDIATRÍA PSICOSOCIAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 17.2C

QUÉ TIENES QUE VER

1 Borde circular

DIAGNÓSTICO

Quemadura en guante

Mano quemada con borde circular.

CONDUCTA INICIAL

Maltrato: hospitalizar y proteger.

2.01.1.138 **Maltrato infantil**

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Escaldadura accidental.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 28** Tema 18.28

Clase 18.28 en video

15 TEMA 18.28 · PEDIATRÍA PSICOSOCIAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

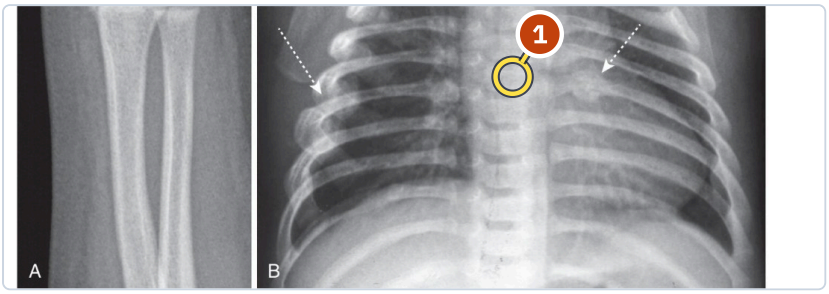


Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 409

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura costal posterior

DIAGNÓSTICO

Fracturas sugerentes de maltrato

Fracturas metafisarias en esquina y costales posteriores.

CONDUCTA INICIAL

Serie ósea completa.

2.01.1.138 Maltrato infantil

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Osteogénesis imperfecta.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 28
Tema 18.28

Clase 18.28 en video

16 TEMA 18.28 · PEDIATRÍA PSICOSOCIAL

FONDO DE OJO

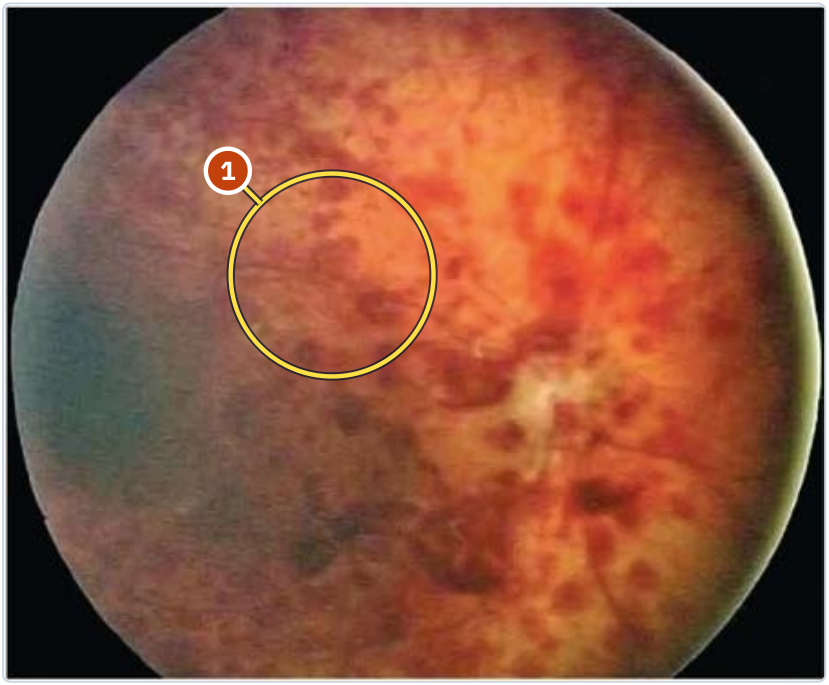


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 670.13

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hemorragias

DIAGNÓSTICO

Hemorragias retinianas en el niño sacudido

Hemorragias múltiples en todas las capas.

CONDUCTA INICIAL

Lactante con TEC: fondo de ojo.

2.01.1.138 Maltrato infantil

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemorragias del parto: desaparecen en semanas.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P150 «Un lactante de 6 meses es traído por la madre, porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está…» → **Fondo de ojo**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 29
Tema 18.28

Clase 18.28 en video

17 TEMA 18.5 · BRONQUIOLITIS AGUDA & SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO (SBO)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 52

QUÉ TIENES QUE VER

1 Retracción

DIAGNÓSTICO

Dificultad respiratoria en la bronquiolitis

Retracción y aleteo nasal.

CONDUCTA INICIAL

Soporte: oxígeno si satura < 92%.

2.01.1.020 Bronquiolitis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Neumonía.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P72 «Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociada a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad…» → **Virus respiratorio sincicial**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 37
Tema 18.5

Clase 18.5 en video

18 TEMA 18.5 · BRONQUIOLITIS AGUDA & SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO (SBO)

IMAGEN RADIOLÓGICA

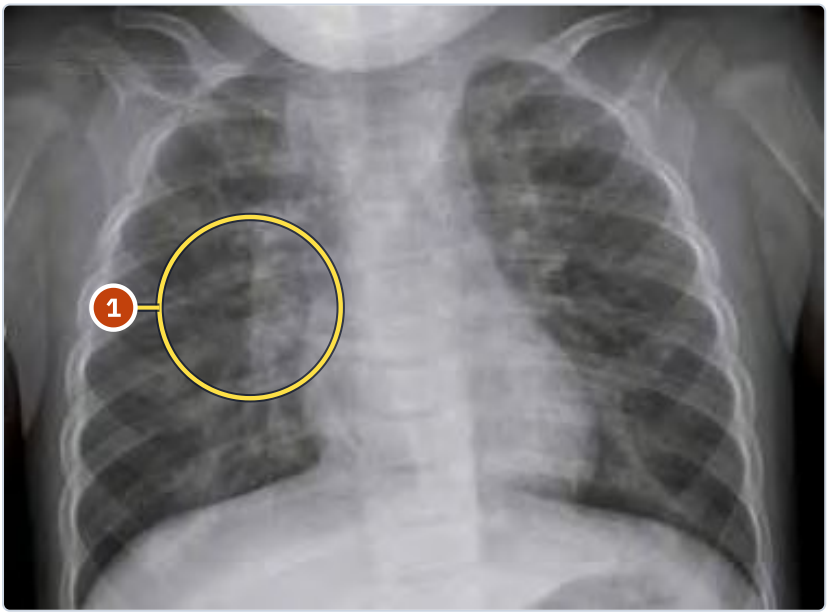


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 52

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hiperinsuflación

DIAGNÓSTICO

Bronquiolitis: hiperinsuflación

Pulmones hiperinsuflados con aplanamiento diafragmático.

CONDUCTA INICIAL

La Rx no es de rutina.

2.01.1.020 Bronquiolitis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

2.01.1.028 Síndrome bronquial obstructivo — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Neumonía: consolidación.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 37
Tema 18.5

Clase 18.5 en video

19 TEMA 18.6 · LARINGITIS AGUDA OBSTRUCTIVA / CROUP

IMAGEN RADIOLÓGICA

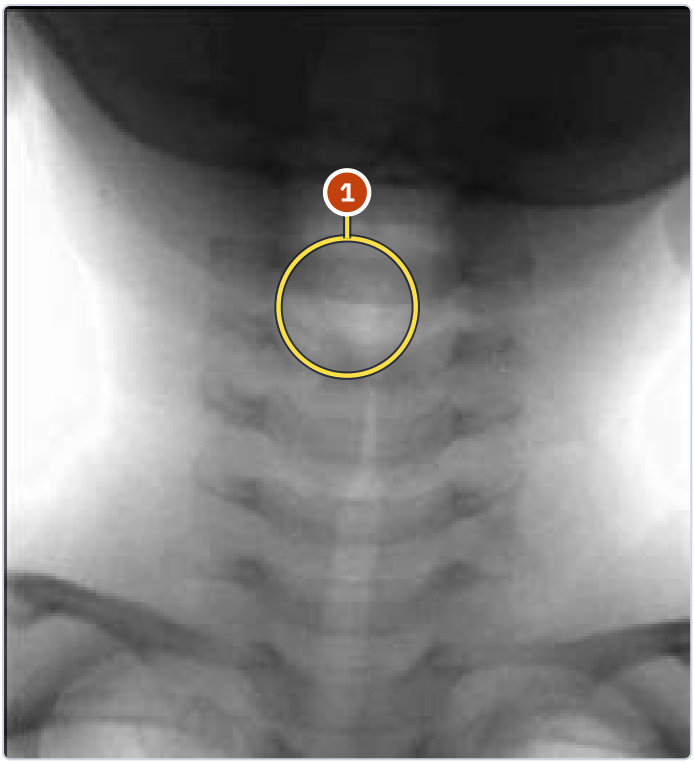


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3220

QUÉ TIENES QUE VER

1 Subglotis estrecha

DIAGNÓSTICO

Signo del campanario

Estrechamiento subglótico.

CONDUCTA INICIAL

Croup: dexametasona.

2.01.1.025 Laringitis

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Epiglotitis: pulgar.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P133 «Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad…» → **Laringitis aguda obstructiva**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 42
Tema 18.6

Clase 18.6 en video

20 TEMA 18.6 · LARINGITIS AGUDA OBSTRUCTIVA / CROUP

ENDOSCOPÍA

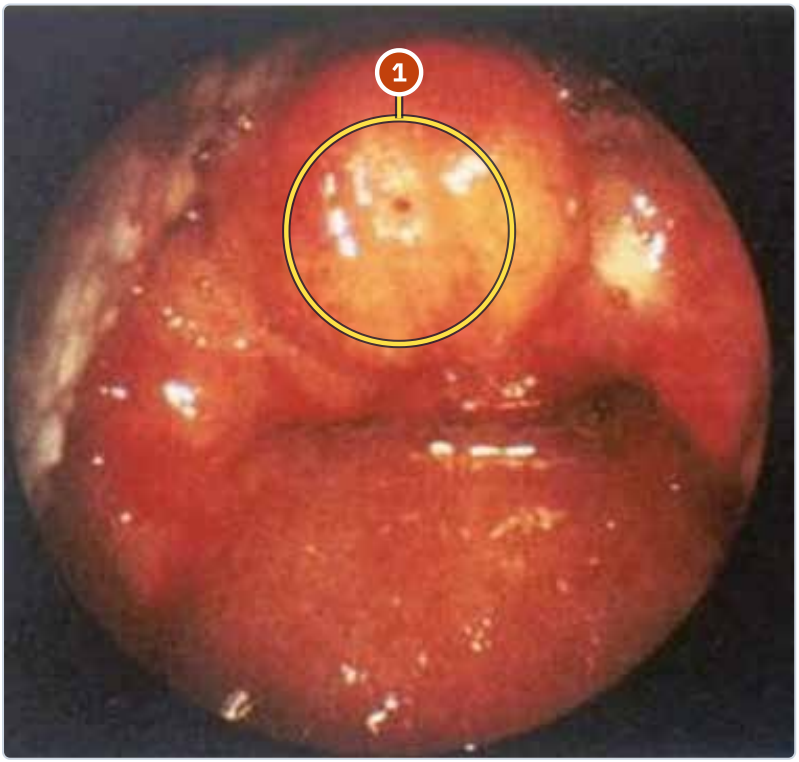


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 50

QUÉ TIENES QUE VER

1 Epiglotis

DIAGNÓSTICO

Epiglotis rojo cereza

Epiglotitis.

CONDUCTA INICIAL

Vía aérea en pabellón.

2.01.2.018 Obstrucción de vía aérea superior

Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Croup.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 42
Tema 18.6

Clase 18.6 en video

21 TEMA 18.6 · LARINGITIS AGUDA OBSTRUCTIVA / CROUP

IMAGEN RADIOLÓGICA

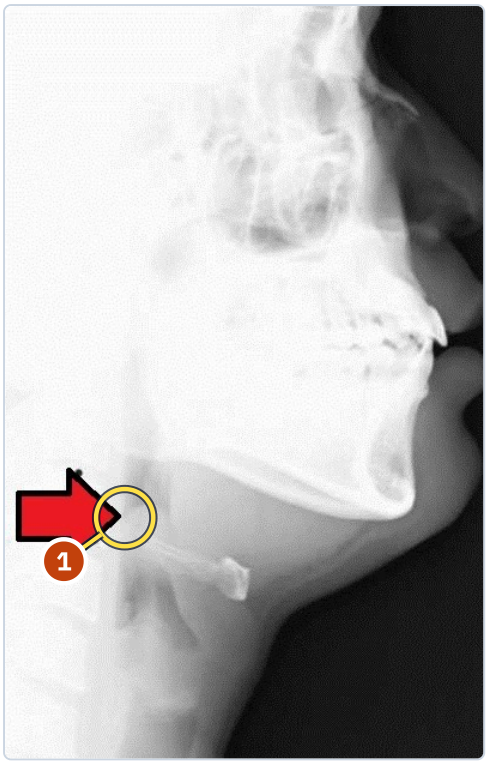


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Epiglotis

DIAGNÓSTICO

Signo del pulgar

Epiglotis engrosada.

CONDUCTA INICIAL

No examinar la faringe.

2.01.2.018 **Obstrucción de vía aérea superior**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Croup.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 42** Tema 18.6

Clase 18.6 en video

22 TEMA 18.7 · NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) PEDIÁTRICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

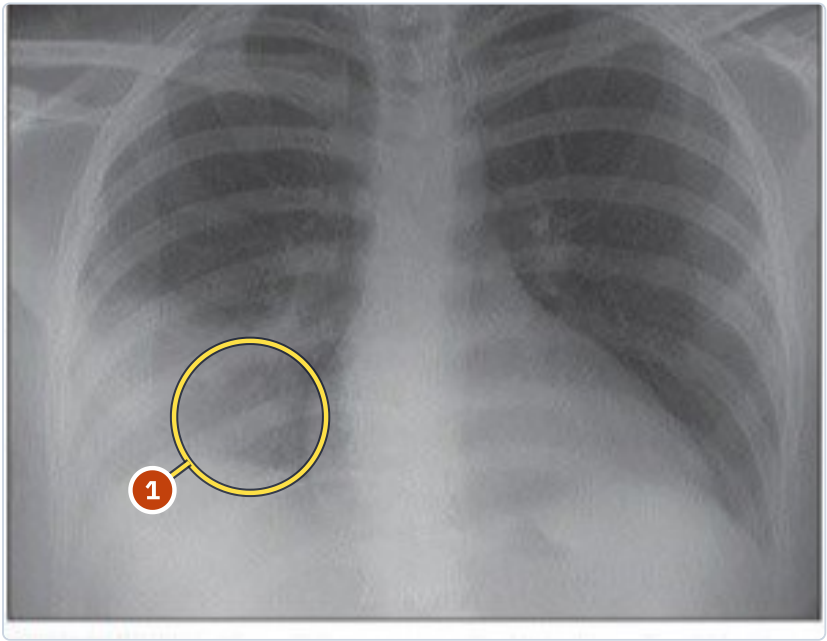


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 345

QUÉ TIENES QUE VER

1 Consolidación

DIAGNÓSTICO

Neumonía lobar

Consolidación del lóbulo inferior.

CONDUCTA INICIAL

Amoxicilina.

2.01.1.024 **Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

2.01.4.001 **Radiografía de tórax**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Atelectasia.

PREGUNTA REAL — **Julio 2017 · P45** «Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucupurulenta, de 2 días de evolución. Además…» → **Streptococcus pneumoniae**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 47** Tema 18.7

Clase 18.7 en video

23 TEMA 18.7 · NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) PEDIÁTRICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

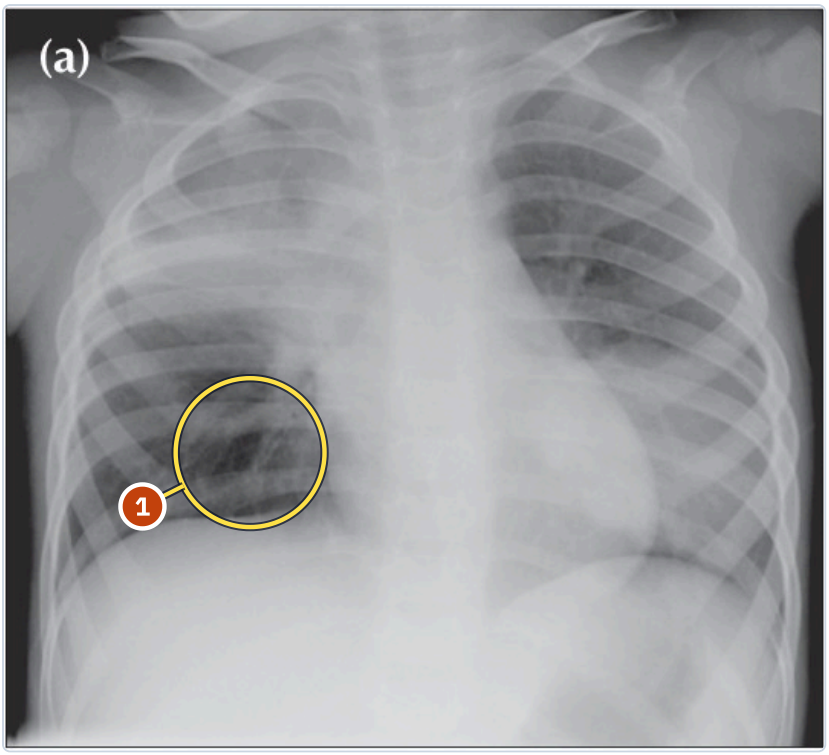


Imagen: The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 14.12

QUÉ TIENES QUE VER

1 Opacidad

DIAGNÓSTICO

Neumonía redonda

Opacidad redondeada.

CONDUCTA INICIAL

Neumococo: antibiótico; no es tumor.

2.01.1.024 **Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Masa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 47** Tema 18.7

Clase 18.7 en video

24 TEMA 18.7 · NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) PEDIÁTRICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

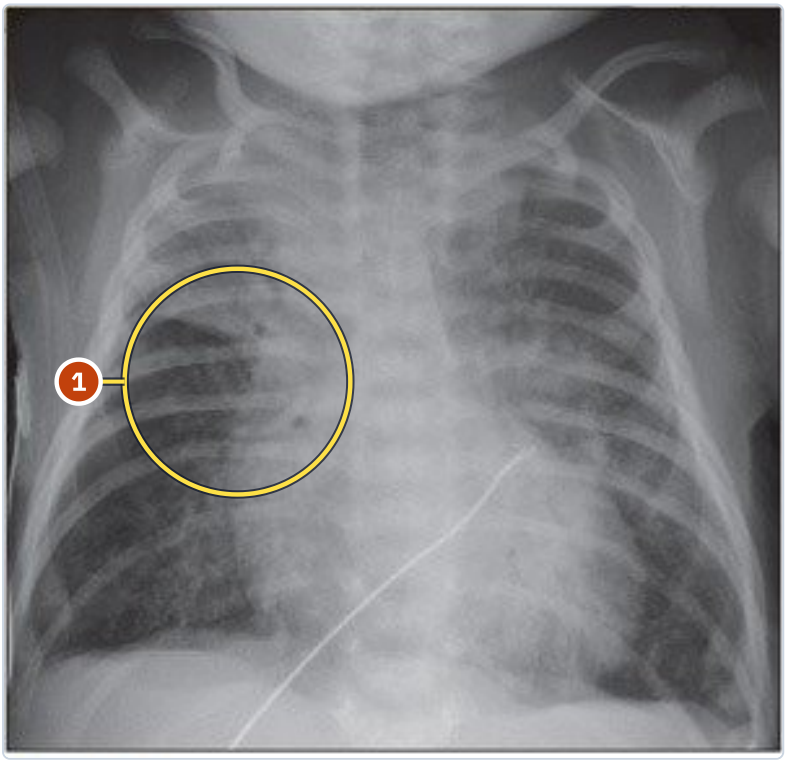


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 696

QUÉ TIENES QUE VER

1 Infiltrado

DIAGNÓSTICO

Infiltrado intersticial

Patrón intersticial bilateral.

CONDUCTA INICIAL

Viral o atípica: macrólido en escolares.

2.01.1.024 **Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Bronquiolitis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 46** Tema 18.7

Clase 18.7 en video

25 TEMA 18.7 · NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) PEDIÁTRICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

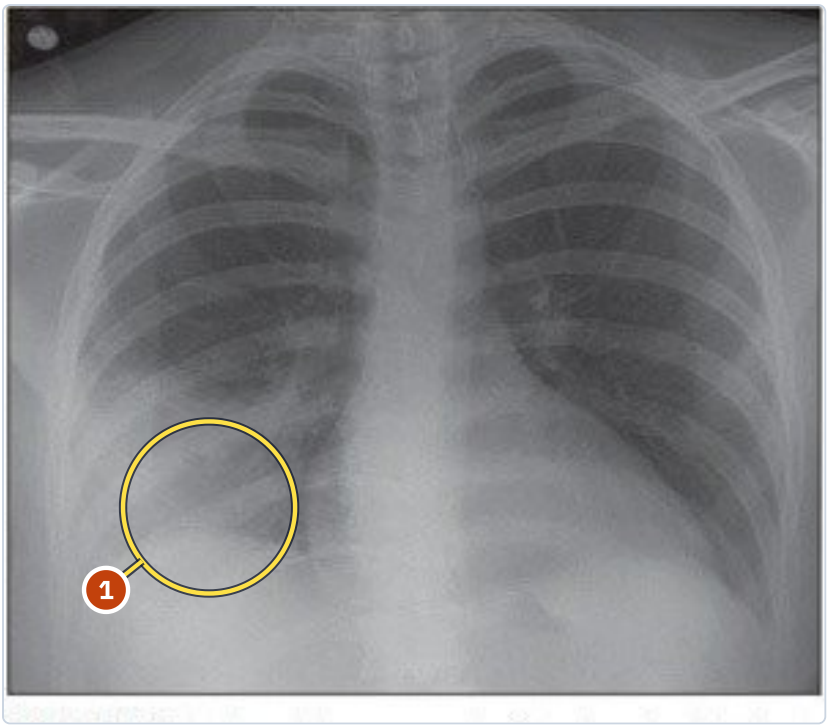


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 345

QUÉ TIENES QUE VER

1 Consolidación

DIAGNÓSTICO

Consolidación con broncograma

Opacidad basal.

CONDUCTA INICIAL

Hospitalizar si hay criterios.

2.01.1.024 **Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Derrame.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 46** Tema 18.7

Clase 18.7 en video

26 TEMA 18.8 · CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AÉREA

IMAGEN RADIOLÓGICA

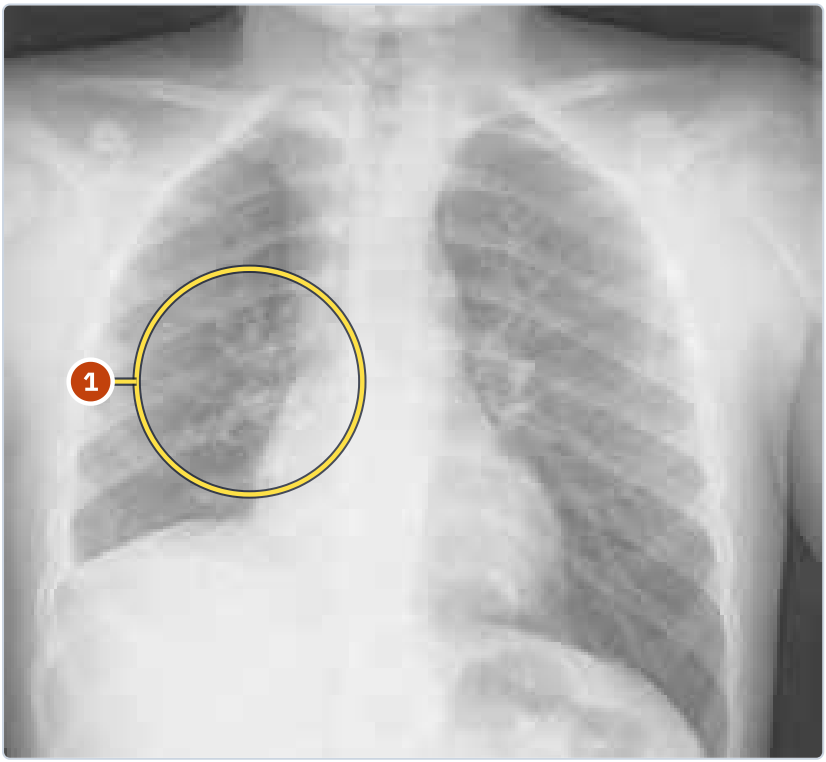


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 59

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hiperinsuflación

DIAGNÓSTICO

Cuerpo extraño en el bronquio derecho

Atrapamiento aéreo unilateral.

CONDUCTA INICIAL

Broncoscopía rígida.

2.01.2.003 **Aspiración cuerpo extraño**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.5.016 **Fibrobroncoscopía**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Asma.

PREGUNTA REAL

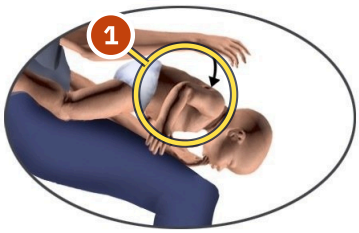
Julio 2025 · P64 «Niño de 3 años con tos súbita, sibilancias unilaterales y disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho. Los padres refieren que estaba…» → **Broncoscopía rígida con extracción del cuerpo extraño**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 52** Tema 18.8

Clase 18.8 en video

27 TEMA 18.8 · CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AÉREA

ESQUEMA



Golpes en la espalda



Compresiones torácicas

Imagen: Wikimedia Commons «Heimlich Infant.png», CC BY-SA 4.0, BruceBlaus

QUÉ TIENES QUE VER

1 Golpes en la espalda

DIAGNÓSTICO

Desobstrucción en el lactante

Golpes en la espalda y compresiones torácicas.

CONDUCTA INICIAL

Menor de 1 año: 5 golpes y 5 compresiones.

2.01.5.004 Maniobra de Heimlich — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Heimlich: mayores de 1 año.

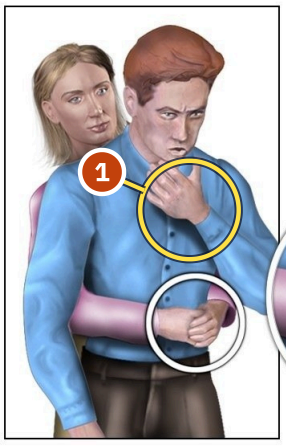
PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 52** Tema 18.8

Clase 18.8 en video

28 TEMA 18.8 · CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AÉREA

ESQUEMA



Heimlich en el adulto



Heimlich en el niño

Imagen: Wikimedia Commons «Heimlich Adult & Child.png», CC BY-SA 4.0, BruceBlaus

QUÉ TIENES QUE VER

1 Puño sobre el epigastrio

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Heimlich

Compresiones abdominales en el adulto y en el niño.

CONDUCTA INICIAL

Niño consciente que no puede toser.

2.01.5.004 Maniobra de Heimlich — examen/procedimiento

6.03.5.011 Maniobra de Heimlich — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Lactante: golpes en la espalda.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P73** «Un niño de 7 años, mientras estaba comiendo, presenta agitación súbita, asociada a imposibilidad de respirar. No puede toser, hablar ni llorar....» → **Abrazarlo por detrás y realizar compresiones subxifoideas**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 52** Tema 18.8

Clase 18.8 en video

29 TEMA 18.23 · CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

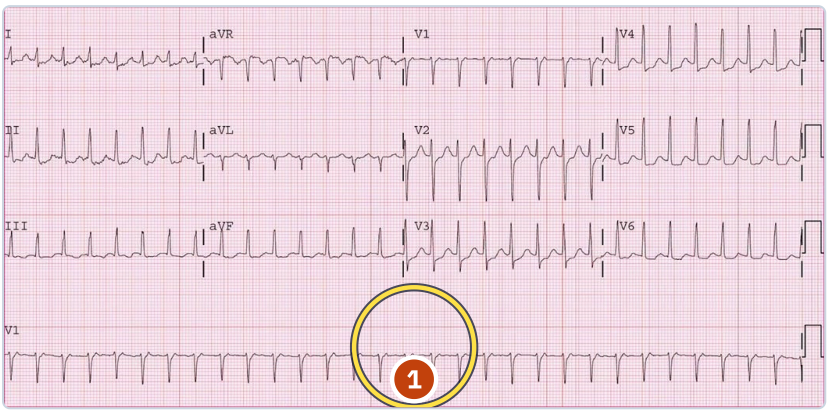


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 809

QUÉ TIENES QUE VER

1 QRS estrecho regular

DIAGNÓSTICO

Taquicardia supraventricular

QRS estrecho regular sin onda P.

CONDUCTA INICIAL

Estable: maniobras vagales y adenosina; inestable: cardioversión.

2.01.1.049 Arritmias — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Taquicardia sinusal.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P29 «Lactante con FC 280 lpm regular, soporoso, pulsos femorales disminuidos, no se puede medir PA. ¿Cual es la conducta?:» → **Cardioversión**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 57
Tema 18.23

Clase 18.23 en video

30 TEMA 18.23 · CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

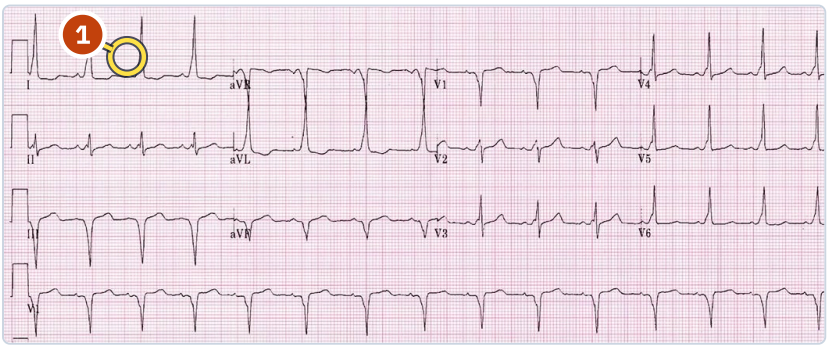


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 809

QUÉ TIENES QUE VER

1 Onda delta

DIAGNÓSTICO

Preexcitación (WPW)

PR corto y onda delta.

CONDUCTA INICIAL

Evitar bloqueadores AV en FA preexcitada.

2.01.1.049 Arritmias — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bloqueo de rama.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 57
Tema 18.23

Clase 18.23 en video

31 TEMA 18.23 · CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

ECOGRAFÍA

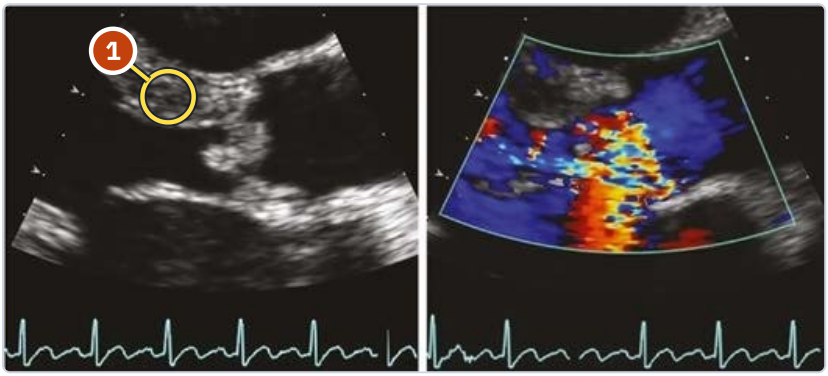


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 486.2

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vegetación

DIAGNÓSTICO

Vegetaciones en la ecografía

Masa móvil sobre una válvula.

CONDUCTA INICIAL

Hemocultivos y antibióticos.

2.01.1.051 **Endocarditis infecciosa**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Trombo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 57** Tema 18.23

Clase 18.23 en video

32 TEMA 18.23 · CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

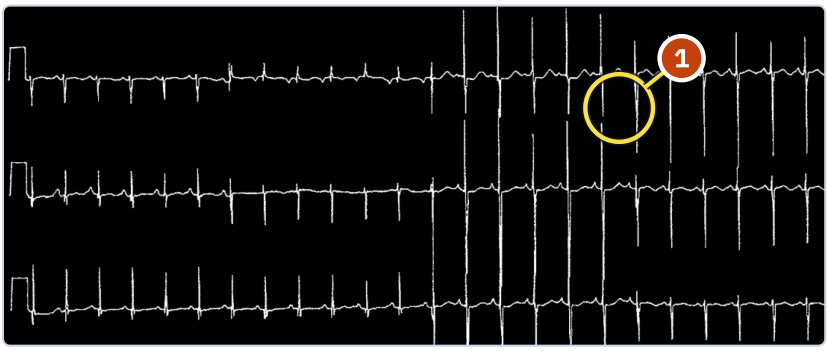


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 472.2

QUÉ TIENES QUE VER

1 R prominente

DIAGNÓSTICO

ECG normal de un recién nacido

Eje a la derecha y R grande en V1.

CONDUCTA INICIAL

Normal a esta edad.

2.01.4.012 **Electrocardiograma**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hipertrofia ventricular derecha del adulto.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 56** Tema 18.23

Clase 18.23 en video

33 TEMA 18.23 · CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

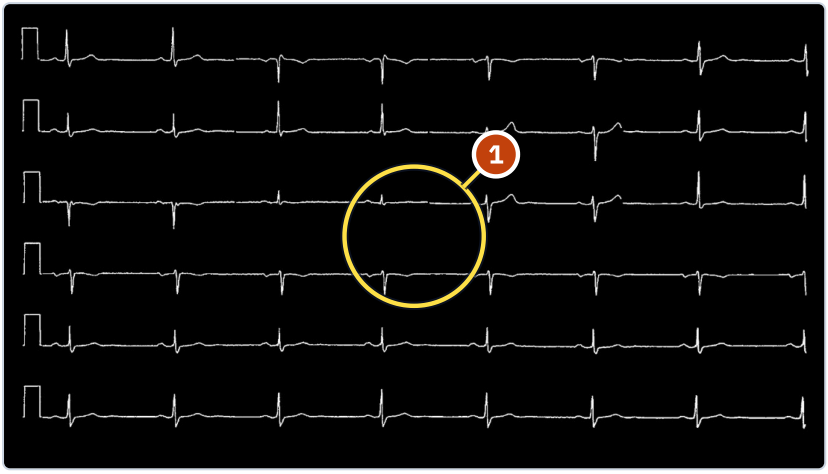


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 472.4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Derivaciones

DIAGNÓSTICO

ECG normal de un niño de 3 años

Eje 60° y R/S menor de 1 en V1.

CONDUCTA INICIAL

El ECG cambia con la edad.

2.01.4.012 **Electrocardiograma**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Patológico.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

p. 56

Tema 18.23

Clase 18.23 en video

34 TEMA 18.24 · REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA, INTOXICACIONES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

ENDOSCOPÍA

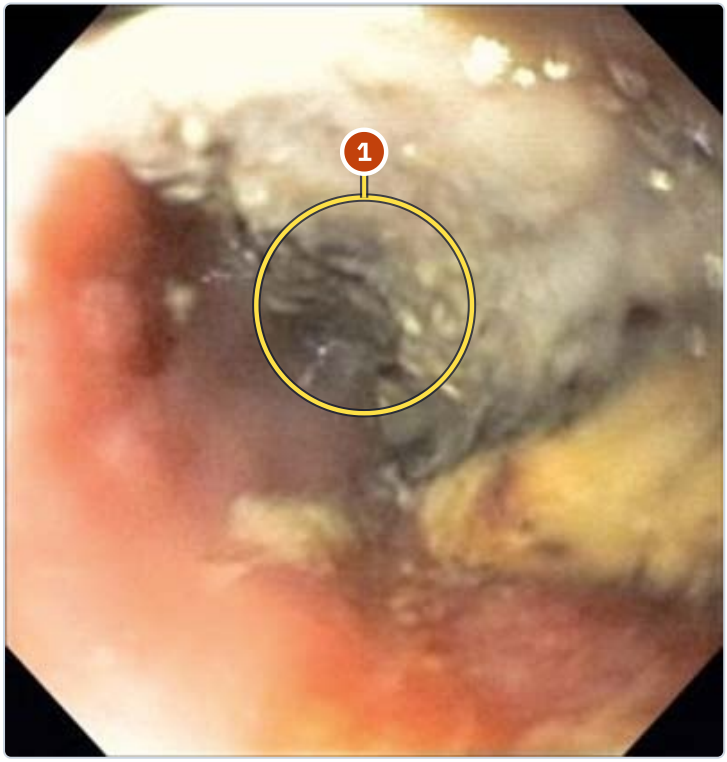


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 373.3 (pila de botón)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Necrosis

DIAGNÓSTICO

Lesión esofágica grave por cáusticos

Mucosa necrótica.

CONDUCTA INICIAL

No inducir vómito; endoscopía en 12–24 h.

2.01.2.014 **Intoxicaciones**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esofagitis péptica.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P40 «Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por…» → **Antidepresivos tricíclicos**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

p. 61

Tema 18.24

Clase 18.24 en video

35 TEMA 18.10 · EXANTEMAS INFANTILES

FOTO CLÍNICA

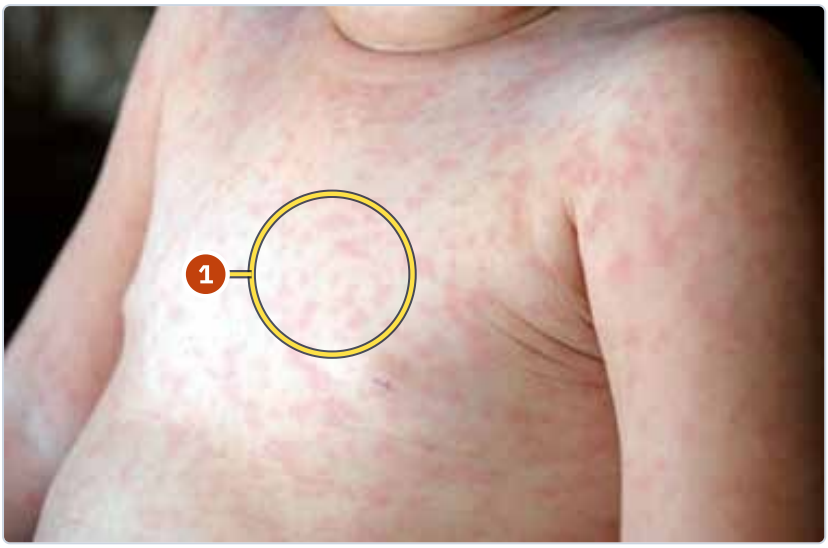


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 101

QUÉ TIENES QUE VER

1 Exantema

DIAGNÓSTICO

Exantema súbito

Exantema que aparece al bajar la fiebre.

CONDUCTA INICIAL

Sintomático.

2.01.1.009 Exantemas virales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Sarampión: fiebre con exantema.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P70 «Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema…» → **Exantema súbito**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 74
Tema 18.10

Clase 18.10 en video

36 TEMA 18.10 · EXANTEMAS INFANTILES

FOTO CLÍNICA

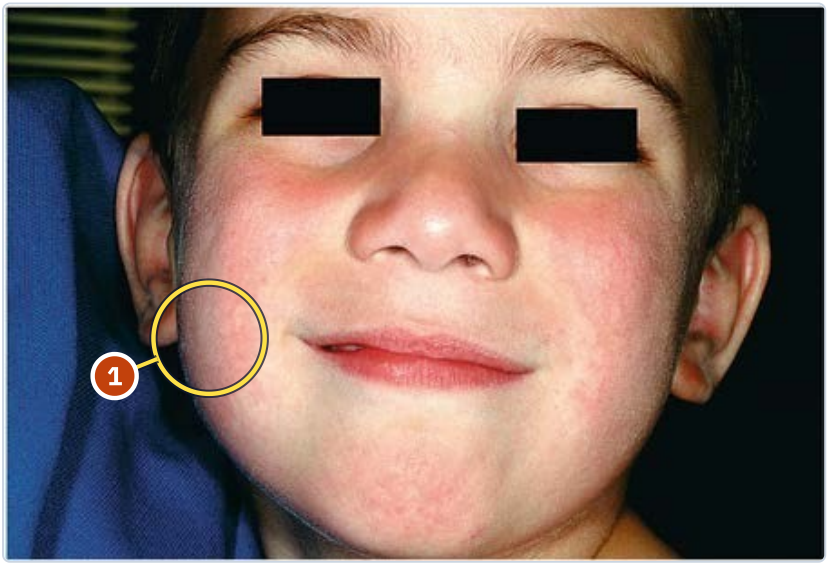


Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 2548

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mejilla roja

DIAGNÓSTICO

Eritema infeccioso: signo de la bofetada

Mejillas rojas.

CONDUCTA INICIAL

Parvovirus B19: ojo con embarazadas y anemias hemolíticas.

2.01.1.009 Exantemas virales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Escarlatina.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 74
Tema 18.10

Clase 18.10 en video

37 TEMA 18.10 · EXANTEMAS INFANTILES

FOTO CLÍNICA

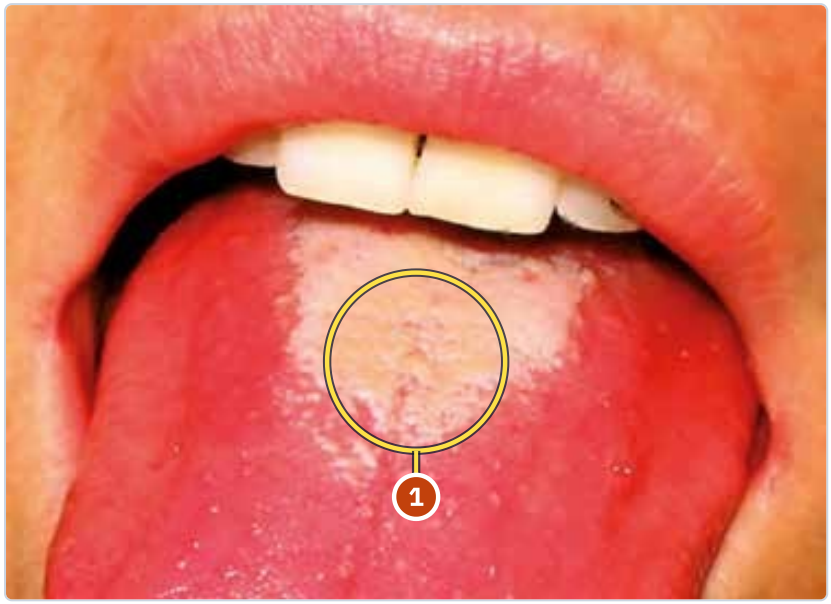


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 102

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lengua saburral

DIAGNÓSTICO

Lengua en fresa blanca

Lengua saburral de la escarlatina inicial.

CONDUCTA INICIAL

Penicilina.

2.01.1.008 Escarlatina

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Kawasaki.

PREGUNTA REAL

Julio 2018 · P96 «Un niño de 6 años, presenta odinofagia intensa, con fiebre y decaimiento. Además, aparece luego un exantema eritematoso, generalizado, que es más…» → **Glomerulonefritis**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 76
Tema 18.10

Clase 18.10 en video

38 TEMA 18.10 · EXANTEMAS INFANTILES

FOTO CLÍNICA

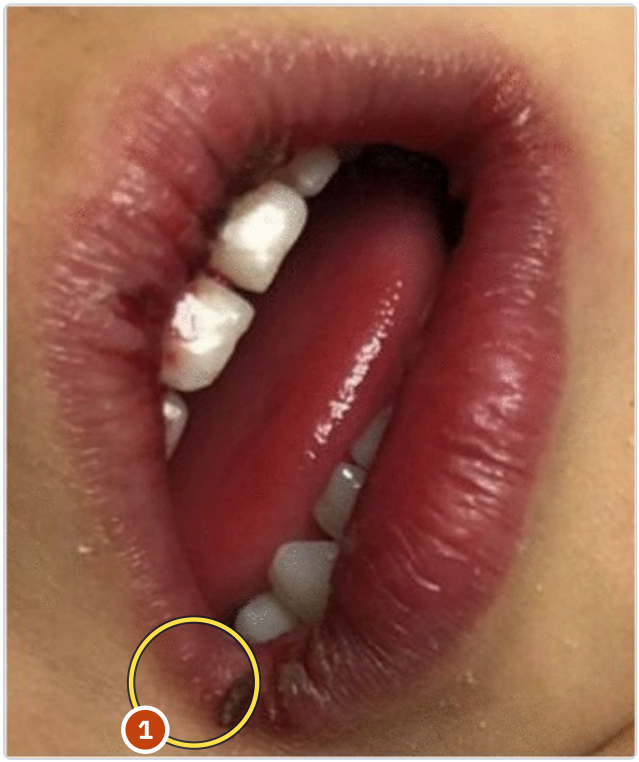


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Labios fisurados

DIAGNÓSTICO

Kawasaki: labios fisurados

Labios rojos y agrietados.

CONDUCTA INICIAL

IGEV y aspirina; ecocardiograma.

2.01.1.058 Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Escarlatina.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P11 «Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y…» → **Enfermedad de Kawasaki**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 74
Tema 18.10

Clase 18.10 en video

39 TEMA 18.10 · EXANTEMAS INFANTILES

FOTO CLÍNICA

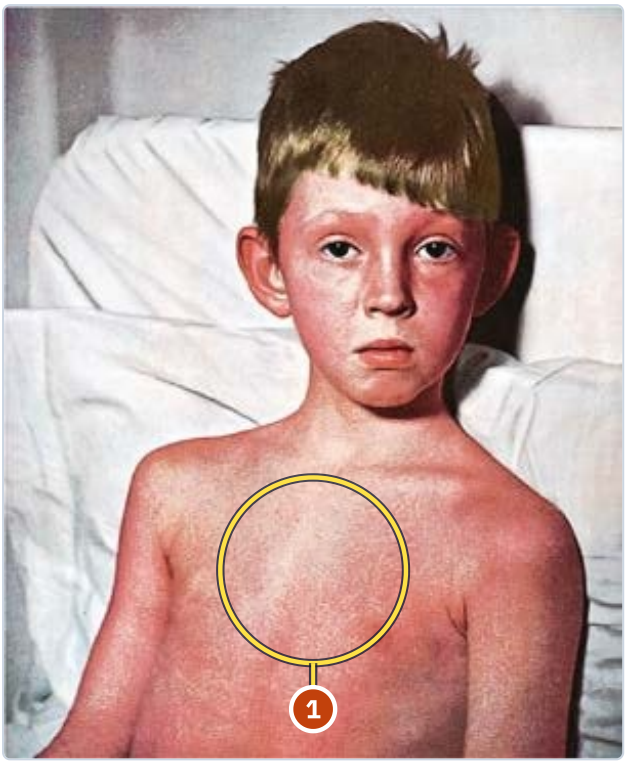


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Exantema

DIAGNÓSTICO

Escarlatina

Exantema en piel de lija y palidez peribucal.

CONDUCTA INICIAL

Penicilina 10 días.

2.01.1.008 Escarlatina

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Exantema viral.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 74
Tema 18.10

Clase 18.10 en video

40 TEMA 18.10 · EXANTEMAS INFANTILES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 2524

QUÉ TIENES QUE VER

1 Catarata

DIAGNÓSTICO

Rubéola congénita: cataratas

Reflejo blanco bilateral.

CONDUCTA INICIAL

Vacunación antes del embarazo.

2.01.1.009 Exantemas virales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Retinoblastoma.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 77
Tema 18.10

Clase 18.10 en video

41 TEMA 18.10 · EXANTEMAS INFANTILES

FOTO CLÍNICA

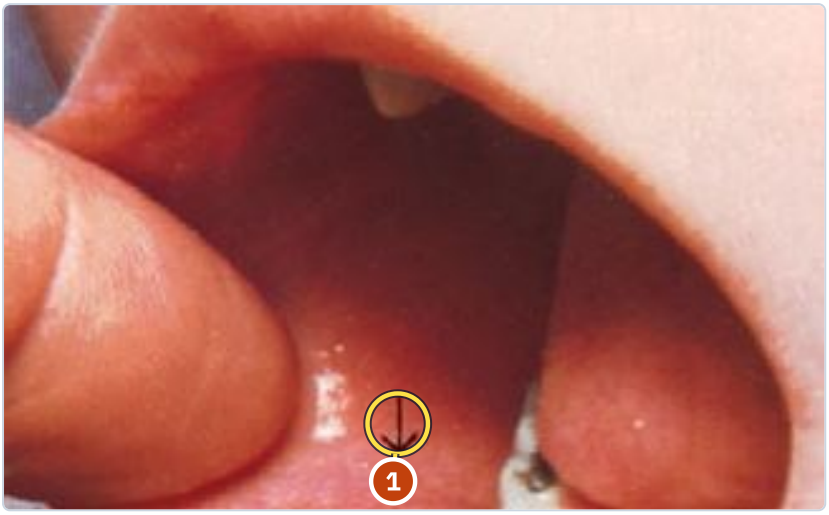


Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 1889

QUÉ TIENES QUE VER

1 Koplik

DIAGNÓSTICO

Manchas de Koplik

Puntos blancos en la mucosa yugal (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Sarampión: aislamiento y notificación.

2.01.1.009 Exantemas virales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Aftas.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 77
Tema 18.10

Clase 18.10 en video

42 TEMA 18.11 · DIARREA AGUDA INFANTIL Y PLANES DE REHIDRATACIÓN ORAL OMS (PLAN A, B, C) Y SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO

FOTO CLÍNICA

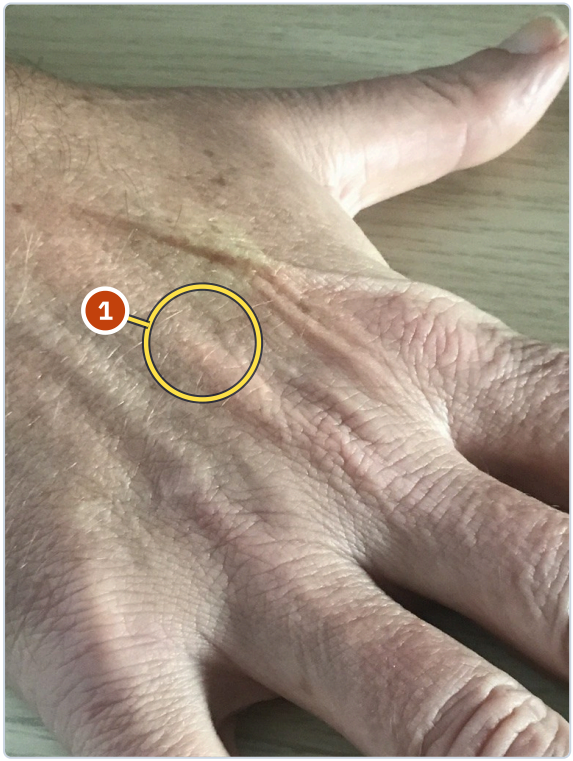


Imagen: Wikimedia Commons «LowSkinTurgor.jpg», CC BY-SA 4.0, DRobert

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegue

DIAGNÓSTICO

Signo del pliegue

La piel tarda en volver.

CONDUCTA INICIAL

Deshidratación: plan B o C.

2.01.2.006 Deshidratación

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Desnutrición.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P138 «Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y…» → **Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en…**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 80
Tema 18.11

Clase 18.11 en video

43 TEMA 18.12 · VÓMITOS EN EL LACTANTE

ECOGRAFÍA

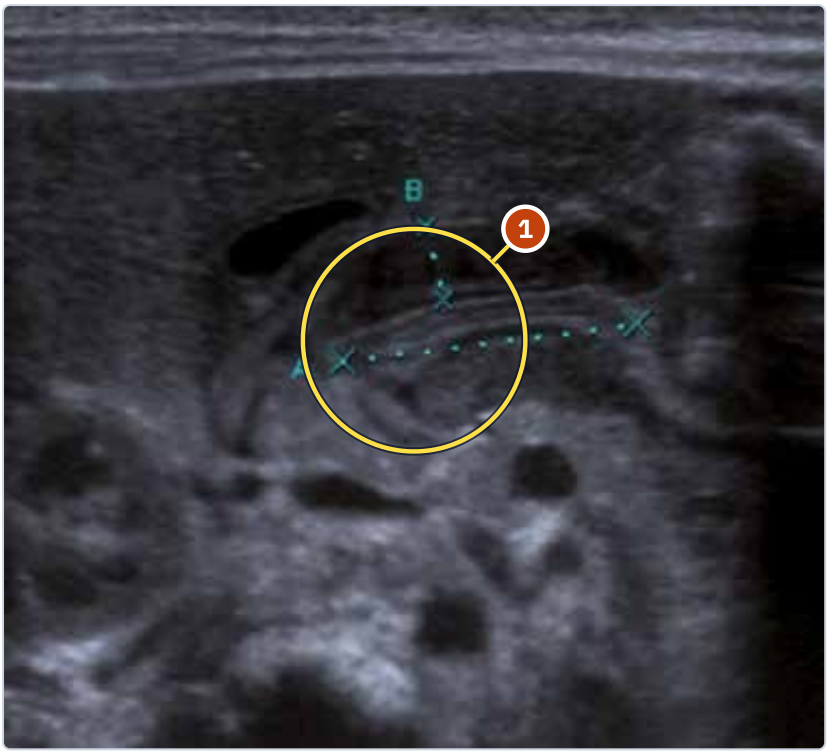


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 65

QUÉ TIENES QUE VER

1 Píloro

DIAGNÓSTICO

Estenosis hipertrófica del píloro

Píloro alargado y engrosado.

CONDUCTA INICIAL

Corregir la alcalosis; pilorotomía.

2.01.1.046 **Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (código repetido en el Perfil oficial)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.4.003 **Ecotomografía abdominal**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

RGE.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P11 «Recién nacido de 4-5 semanas con vómitos postprandiales lácteos, enflaquecido y deshidratado. ¿Cuál es el examen inicial para el estudio?» → **Ecografía abdominal**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 86
Tema 18.12

Clase 18.12 en video

44 TEMA 18.12 · VÓMITOS EN EL LACTANTE

FOTO CLÍNICA

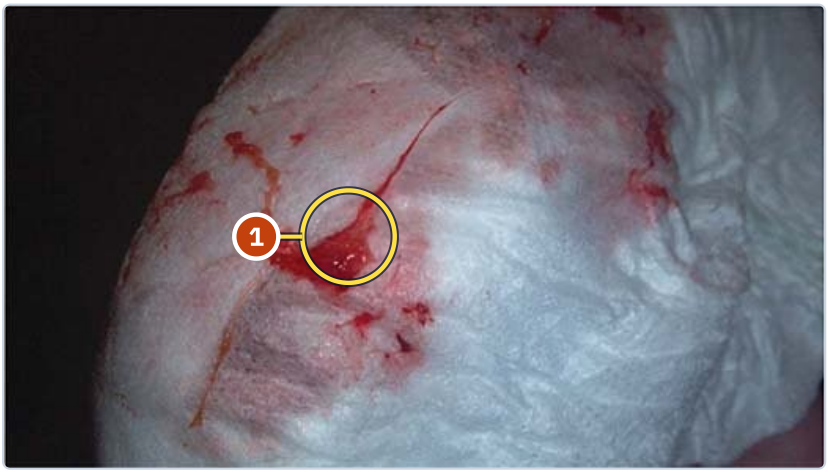


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 500

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sangre

DIAGNÓSTICO

Deposición en jalea de grosella

Sangre con mucus en el pañal.

CONDUCTA INICIAL

Invaginación: ecografía y enema reductor.

2.01.2.019 **Obstrucción intestinal**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fisura anal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 86
Tema 18.12

Clase 18.12 en video

45 TEMA 18.12 · VÓMITOS EN EL LACTANTE

ECOGRAFÍA

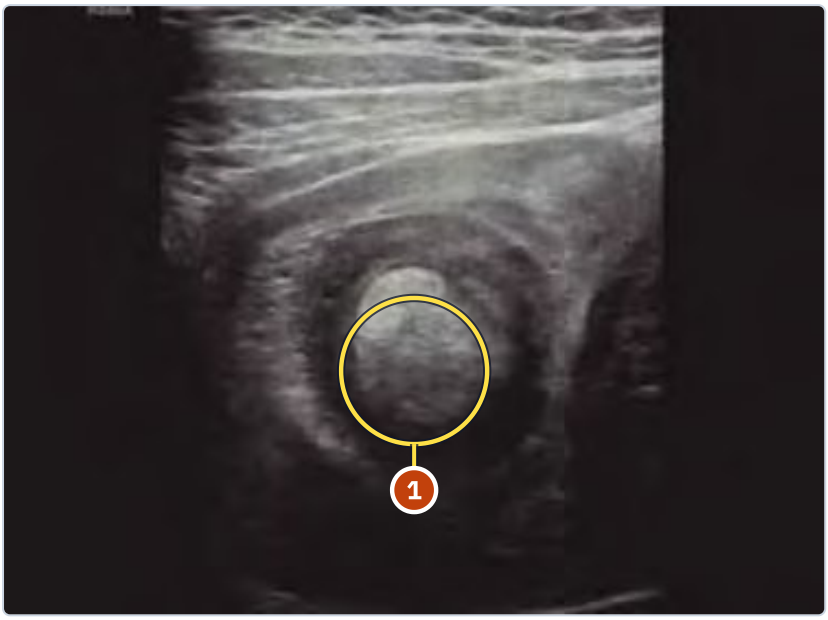


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 70

QUÉ TIENES QUE VER

1 Diana

DIAGNÓSTICO

Imagen en diana

Invaginación ileocólica.

CONDUCTA INICIAL

Reducción con enema.

2.01.2.019 Obstrucción intestinal

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Asa normal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 86
Tema 18.12

Clase 18.12 en video

46 TEMA 18.12 · VÓMITOS EN EL LACTANTE

IMAGEN RADIOLÓGICA

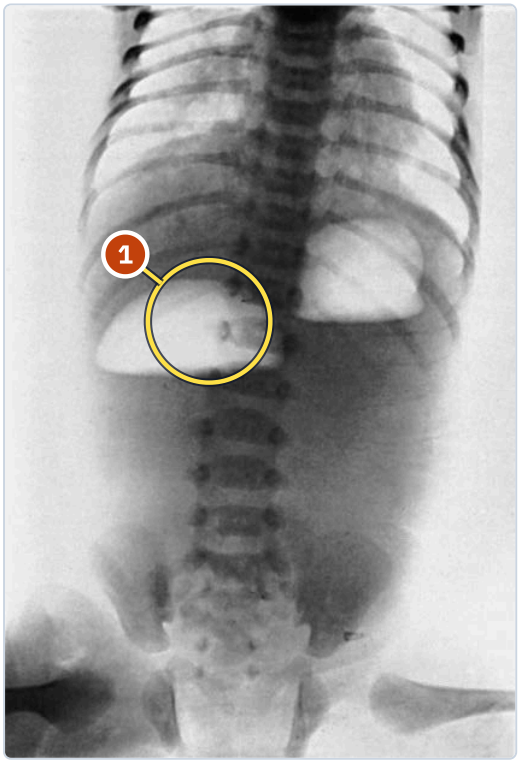


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Doble burbuja

DIAGNÓSTICO

Doble burbuja

Estómago y duodeno dilatados con niveles.

CONDUCTA INICIAL

Atresia duodenal: cirugía.

2.01.2.019 Obstrucción intestinal

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Malrotación.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P33 «Usted evalúa a un recién nacido de término, con antecedente de síndrome de Down, quien, desde el segundo día de vida, presenta vómitos abundantes…» → **Atresia duodenal**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 85
Tema 18.12

Clase 18.12 en video

47 TEMA 18.12 · VÓMITOS EN EL LACTANTE

IMAGEN RADIOLÓGICA

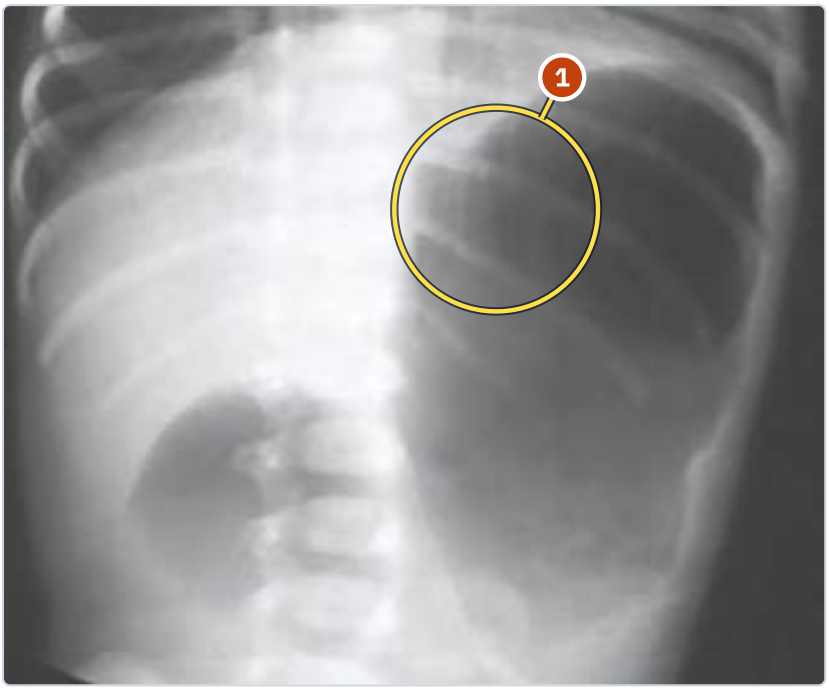


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., Fig. 9.24

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estómago dilatado

DIAGNÓSTICO

Doble burbuja neonatal

Sin gas distal.

CONDUCTA INICIAL

Asociación con síndrome de Down.

2.01.2.019 Obstrucción intestinal

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Estenosis pilórica.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 85** Tema 18.12

Clase 18.12 en video

48 TEMA 18.12 · VÓMITOS EN EL LACTANTE

IMAGEN RADIOLÓGICA

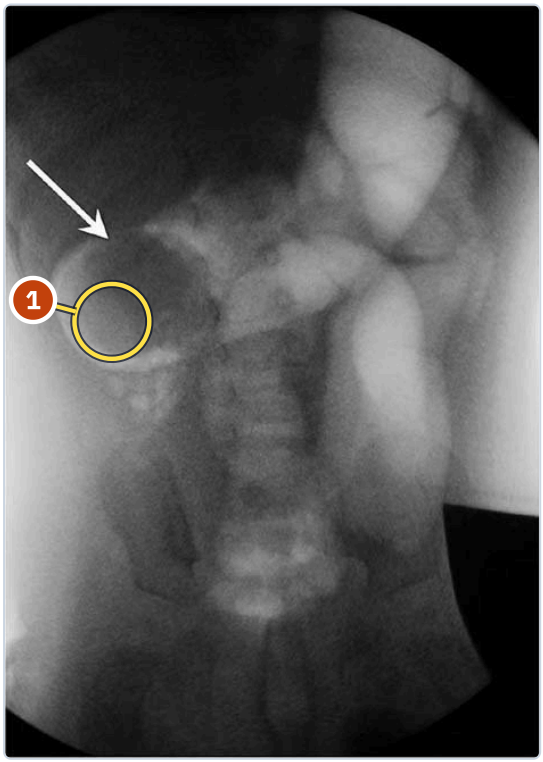


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 501

QUÉ TIENES QUE VER

1 Menisco

DIAGNÓSTICO

Invaginación: signo del menisco

Defecto de relleno en el colon (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Enema reductor.

2.01.2.019 Obstrucción intestinal

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 85** Tema 18.12

Clase 18.12 en video

49 TEMA 18.13 · INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) EN PEDIATRÍA

ESQUEMA

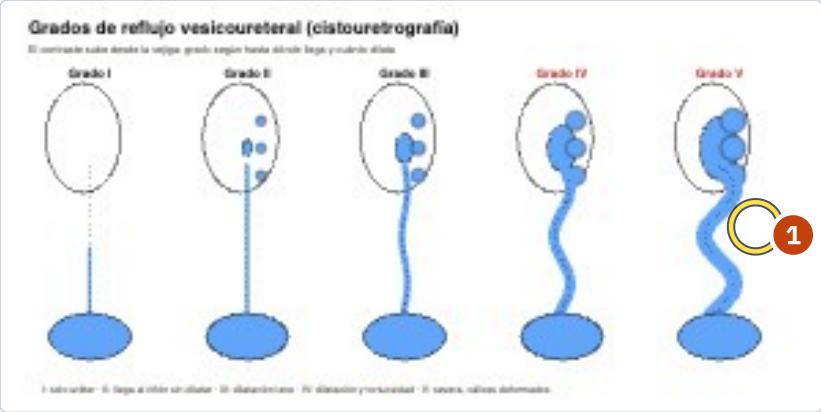


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Grado V

DIAGNÓSTICO

Grados de reflujo vesicoureteral

De I (solo uréter) a V (cálices deformados).

CONDUCTA INICIAL

ITU febril recurrente: uretrocistografía.

2.01.1.062 Infección urinaria — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

4.03.1.021 Reflujo vésico ureteral — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hidronefrosis obstructiva.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P135** «Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor,...» → **Cefadroxilo**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 91** Tema 18.13

Clase 18.13 en video

50 TEMA 18.13 · INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) EN PEDIATRÍA

IMAGEN RADIOLÓGICA

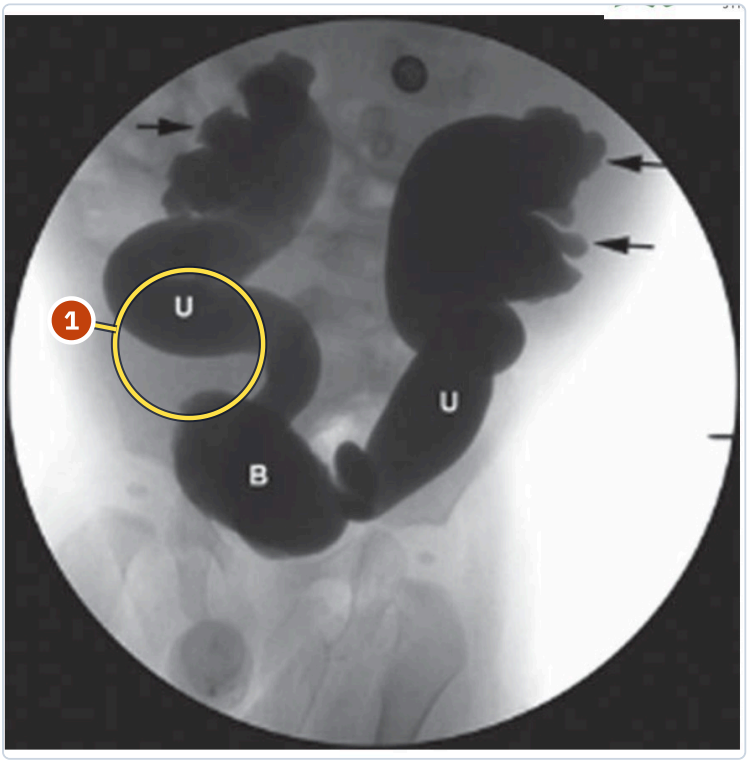


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 316-4A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Uréter dilatado

DIAGNÓSTICO

Reflujo vesicoureteral de alto grado

Uréteres tortuosos y dilatados.

CONDUCTA INICIAL

Profilaxis y cirugía según caso.

4.03.1.021 Reflujo vésico ureteral — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Megauréter obstructivo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 91** Tema 18.13

Clase 18.13 en video

51 TEMA 18.13 · INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) EN PEDIATRÍA

IMAGEN RADIOLÓGICA

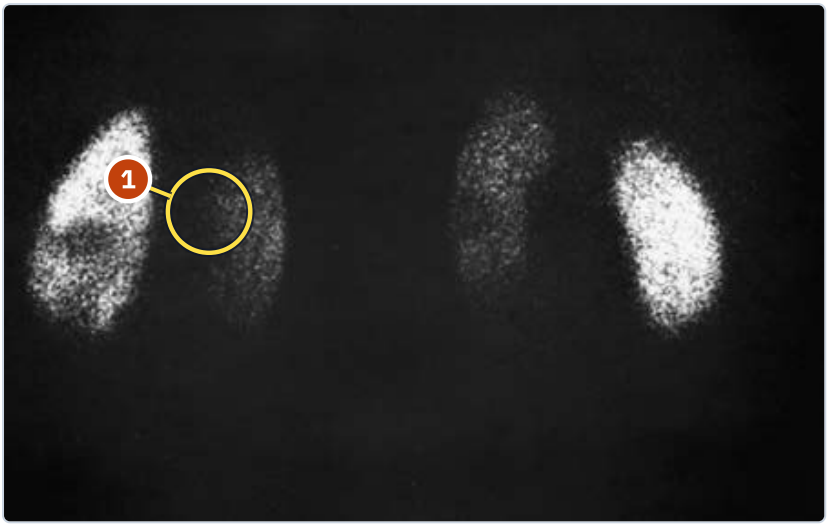


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cicatriz

DIAGNÓSTICO

DMSA con cicatriz cortical

Defecto de captación renal.

CONDUCTA INICIAL

Pielonefritis previa.

1.09.4.007 **Cintigrama renal**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Riñón normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 91** Tema 18.13

Clase 18.13 en video

52 TEMA 18.25 · INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, INFECCIONES RECURRENTES, HEPATOMEGALIA E INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA PEDIÁTRICO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick Dermatology, Fig. 144-7

QUÉ TIENES QUE VER

1 Eccema

DIAGNÓSTICO

Eccema en Wiskott-Aldrich

Eccema con petequias.

CONDUCTA INICIAL

Eccema + plaquetas pequeñas + infecciones.

2.01.1.056 **Inmunodeficiencias**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Dermatitis atópica.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P12** «Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia…» → **Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 98** Tema 18.25

Clase 18.25 en video

53 TEMA 18.15 · ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO & REANIMACIÓN NEONATAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 8

QUÉ TIENES QUE VER

1 Manos sobre el tórax

DIAGNÓSTICO

Compresiones torácicas neonatales

Técnica de los dos pulgares.

CONDUCTA INICIAL

FC < 60 tras ventilar 30 s: compresiones 3:1.

2.01.5.011 **Reanimación neonatal**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ventilación primero.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P59 «Un recién nacido de término nace deprimido, con apnea y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Se estimula, se administra oxígeno y se…» → **Iniciar compresiones torácicas**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 109
Tema 18.15

Clase 18.15 en video

54 TEMA 18.15 · ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO & REANIMACIÓN NEONATAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

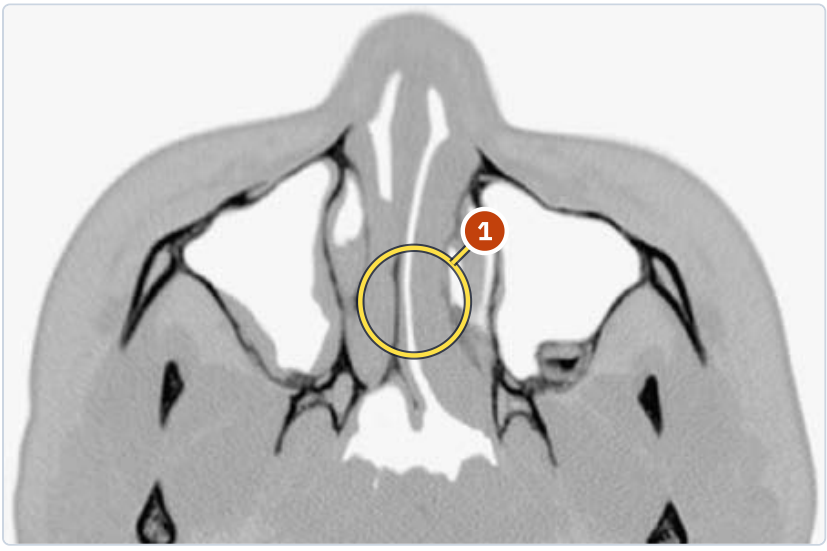


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3188 (Fig. 425.1A)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Atresia

DIAGNÓSTICO

Atresia de coanas

Obstrucción ósea bilateral.

CONDUCTA INICIAL

Recién nacido cianótico que mejora al llorar.

6.03.2.005 **Atresia coanal congénita**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Rinitis.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 109
Tema 18.15

Clase 18.15 en video

55 TEMA 18.16 · EVALUACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL (CAPURRO/BALLARD) & CLASIFICACIÓN PONDERAL NEONATAL

ESQUEMA



Imagen: Test de Capurro (esquema docente)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegues plantares

DIAGNÓSTICO

Test de Capurro

Oreja, mamas, pezón, piel y pliegues plantares.

CONDUCTA INICIAL

Estima la edad gestacional.

2.01.1.128 **RN PEG-GEG**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

2.01.1.123 **Prematurez**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ballard.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P8 «Recién nacido pequeño para la edad gestacional (2.500 g). ¿Qué conducta tomar en relación a la alimentación?» → **Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 115
Tema 18.16

Clase 18.16 en video

56 TEMA 18.16 · EVALUACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL (CAPURRO/BALLARD) & CLASIFICACIÓN PONDERAL NEONATAL

FONDO DE OJO

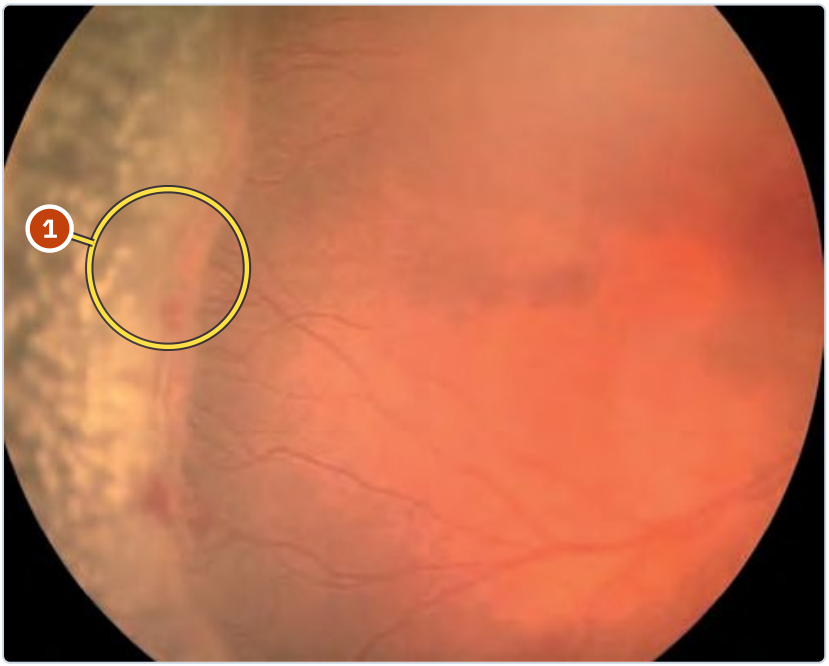


Imagen: Kanski, Clinical Ophthalmology 8.ª ed., p. 577 (Fig. 13.52B)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Láser

DIAGNÓSTICO

Retinopatía del prematuro tratada

Cicatrices de láser.

CONDUCTA INICIAL

Tamizaje en < 32 semanas o < 1.500 g.

6.02.1.022 **Retinopatía del prematuro**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Retina normal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 115
Tema 18.16

Clase 18.16 en video

57 TEMA 18.17 · ICTERICIA NEONATAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bates' Guide to Physical Examination, p. 848

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cara amarilla

DIAGNÓSTICO

Ictericia neonatal

Piel amarilla en la cara.

CONDUCTA INICIAL

Antes de 24 h: siempre patológica.

2.01.1.121 Ictericia neonatal y del primer trimestre
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ictericia por leche materna.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P129 «Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3…» → **Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 119
Tema 18.17

Clase 18.17 en video

58 TEMA 18.17 · ICTERICIA NEONATAL

ESQUEMA

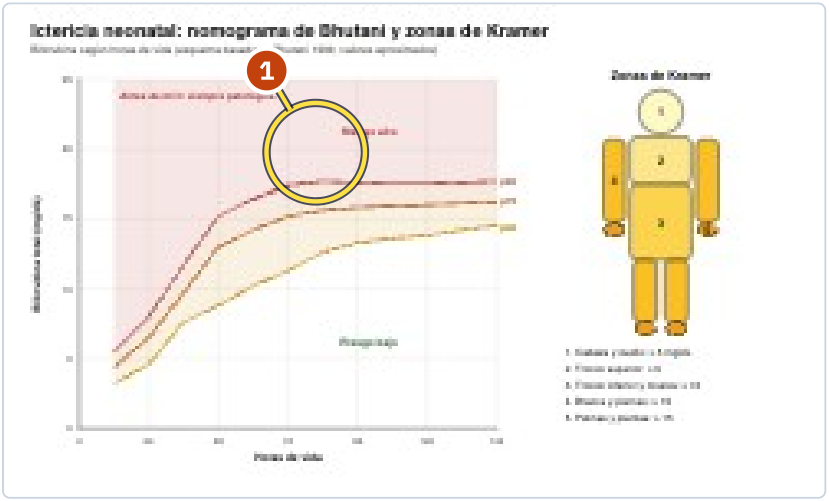


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Zona de alto riesgo

DIAGNÓSTICO

Nomograma de Bhutani y zonas de Kramer

Riesgo según horas de vida.

CONDUCTA INICIAL

Fototerapia según curva.

2.01.1.121 Ictericia neonatal y del primer trimestre
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.4.023 Pruebas hepáticas
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Valor aislado sin edad.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 119
Tema 18.17

Clase 18.17 en video

59 TEMA 18.18 · DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

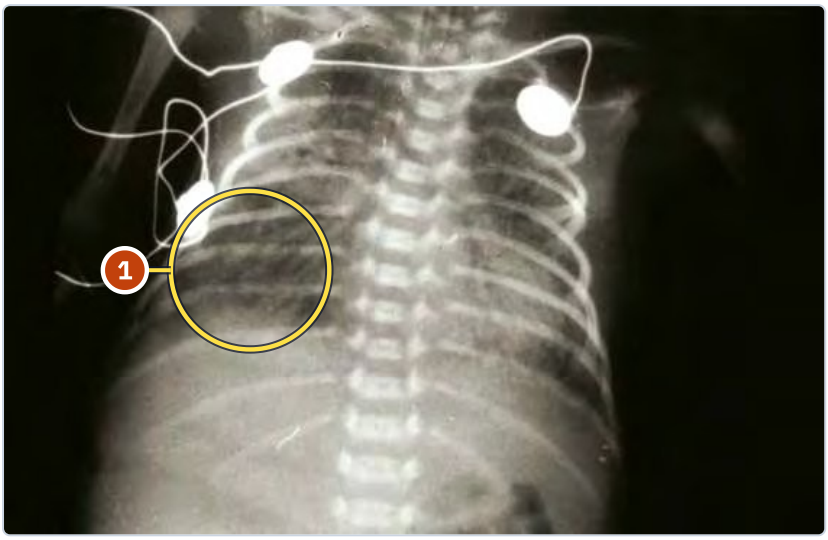


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 19

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vidrio esmerilado

DIAGNÓSTICO

Enfermedad de membrana hialina

Patrón reticulogranular y broncograma.

CONDUCTA INICIAL

Surfactante y CPAP.

2.01.1.126 Síndrome distress respiratorio — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.1.123 Prematurez — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

TTRN.

PREGUNTA REAL

Julio 2016 · P177 «Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria, luego de nacer, con taquipnea,...» → **Taquipnea transitoria**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 123
Tema 18.18

Clase 18.18 en video

60 TEMA 18.18 · DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

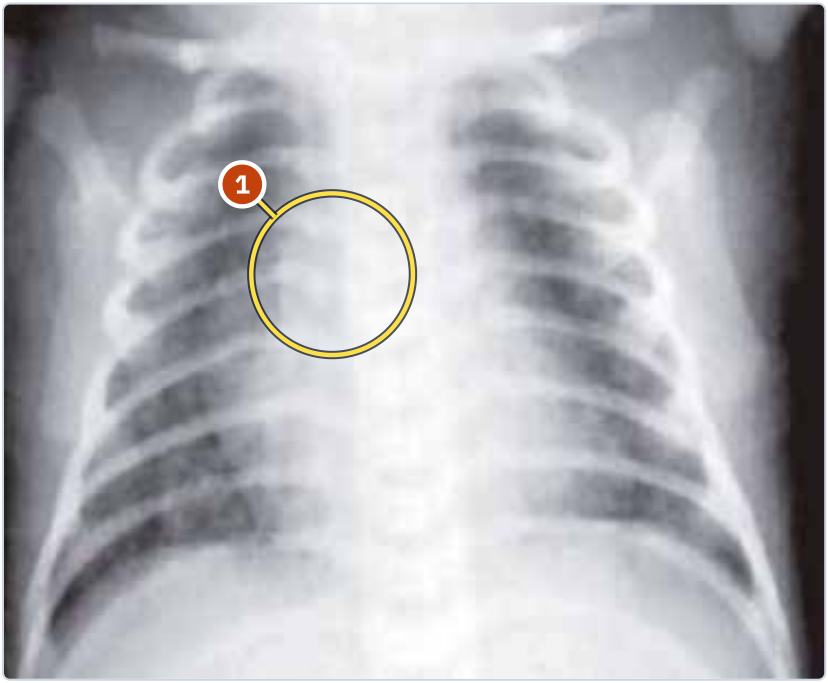


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 18

QUÉ TIENES QUE VER

1 Líquido en cisuras

DIAGNÓSTICO

Taquipnea transitoria

Cisuras marcadas y líquido.

CONDUCTA INICIAL

Se resuelve en 72 h.

2.01.1.126 Síndrome distress respiratorio — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Membrana hialina.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 123
Tema 18.18

Clase 18.18 en video

61 TEMA 18.18 · DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

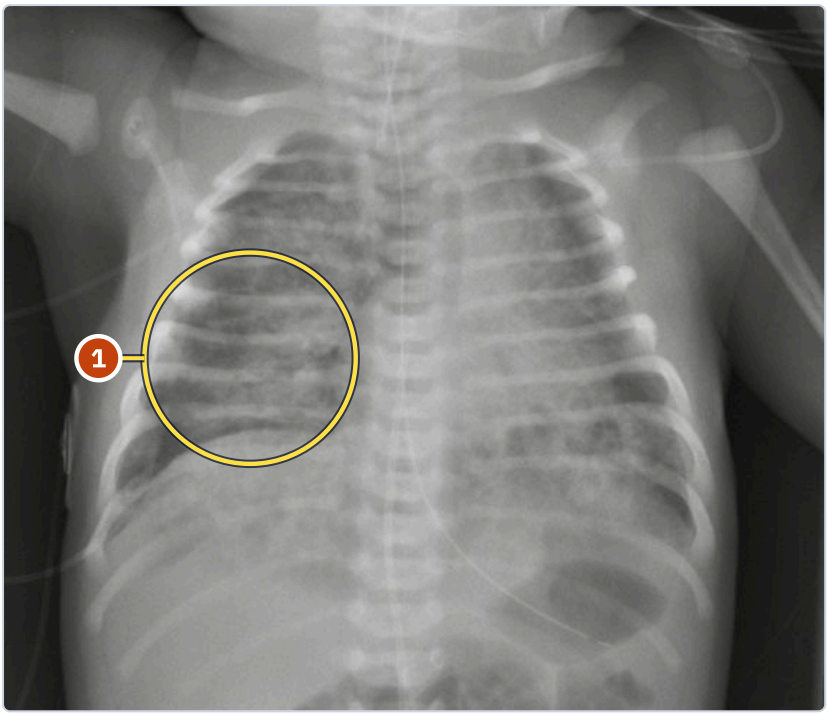


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 20

QUÉ TIENES QUE VER

1 Infiltrados

DIAGNÓSTICO

Aspiración meconial

Infiltrados gruesos con hiperinsuflación.

CONDUCTA INICIAL

Soporte; riesgo de hipertensión pulmonar.

2.01.1.125 **Síndrome aspirativo meconial**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Neumonía neonatal.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P42 «Una paciente de 42 años, embarazada de término ingresa en trabajo de parto. Durante el expulsivo aparecen múltiples desaceleraciones tardías en…» → **Secar, poner en calor radiante, administrar oxígeno y…**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 123
Tema 18.18

Clase 18.18 en video

62 TEMA 18.21 · TAMIZAJE NEONATAL UNIVERSAL EN CHILE

FOTO CLÍNICA

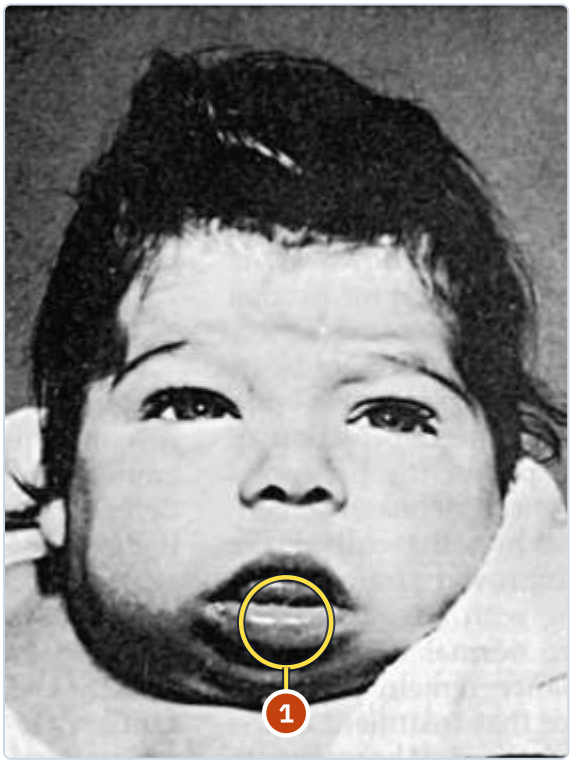


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4372

QUÉ TIENES QUE VER

1 Macroglosia

DIAGNÓSTICO

Hipotiroidismo congénito sin tratar

Macroglosia y facies tosca.

CONDUCTA INICIAL

Tamizaje con TSH.

2.01.1.075 **Hipotiroidismo**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Síndrome de Down.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P53 «Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09…» → **Disminuir la dosis de levotiroxina**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 136
Tema 18.21

Clase 18.21 en video

63 TEMA 18.21 · TAMIZAJE NEONATAL UNIVERSAL EN CHILE

ESQUEMA

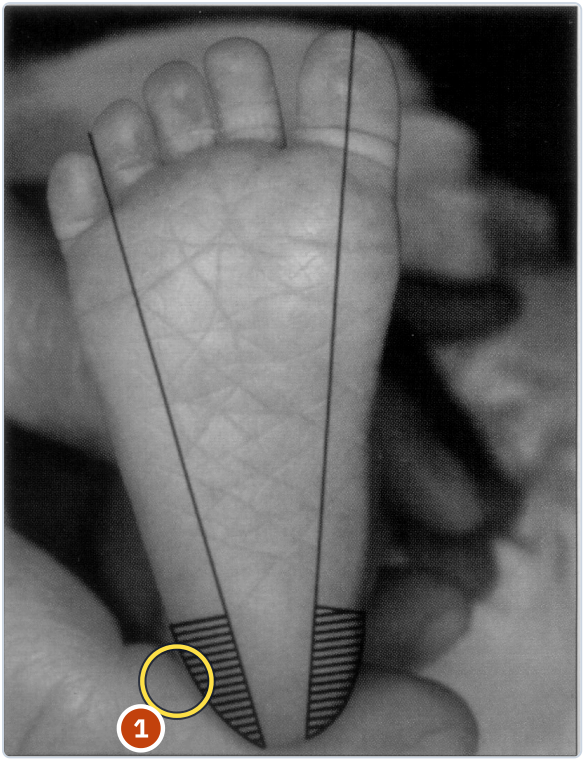


Imagen: Normas Pesquisa PKU/HC MINSAL 2007, Foto 3

QUÉ TIENES QUE VER

1 Zona segura

DIAGNÓSTICO

Zonas de punción del talón

Bordes laterales del talón.

CONDUCTA INICIAL

Toma de muestra del tamizaje neonatal.

2.01.1.075 Hipotiroidismo

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Centro del talón: riesgo de osteomielitis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 136** Tema 18.21

Clase 18.21 en video

64 TEMA 18.21 · TAMIZAJE NEONATAL UNIVERSAL EN CHILE

ESQUEMA



Imagen: Normas Pesquisa PKU/HC MINSAL 2007, Foto 2

QUÉ TIENES QUE VER

1 Gotas

DIAGNÓSTICO

Tarjeta de papel filtro

Gotas de sangre para TSH y PKU.

CONDUCTA INICIAL

Tamizaje neonatal: PKU e hipotiroidismo.

2.01.1.075 Hipotiroidismo

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tamizaje auditivo: emisiones otoacústicas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 136** Tema 18.21

Clase 18.21 en video

65 TEMA 18.22 · DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA (DDC GES N° 23)

ESQUEMA

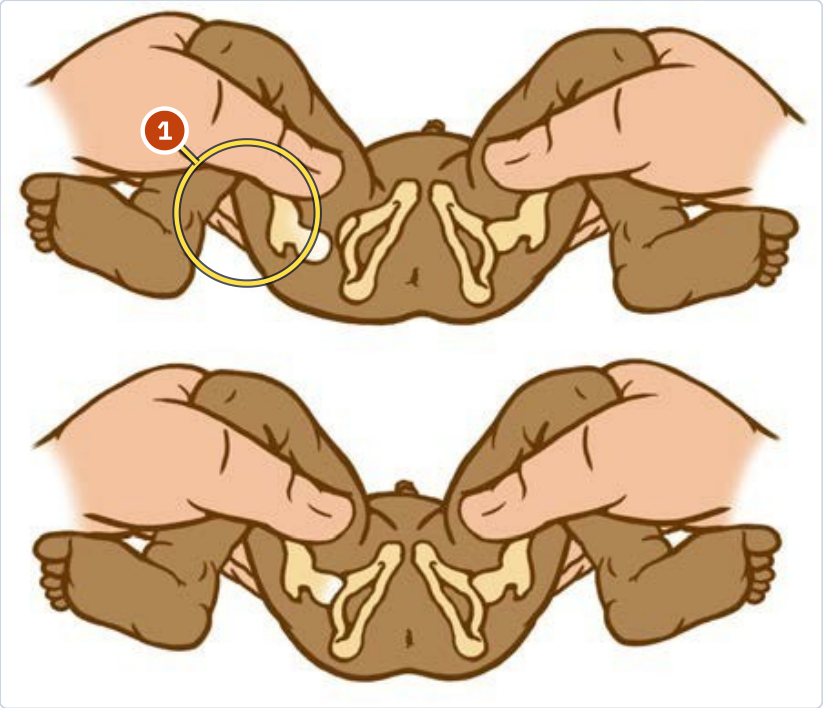


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5430

QUÉ TIENES QUE VER

1 Abducción

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Ortolani

Reduce la cadera luxada.

CONDUCTA INICIAL

Clic positivo: ecografía y derivar.

2.01.1.092 **Displasia de caderas**

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Clic de partes blandas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 141** Tema 18.22

Clase 18.22 en video

66 TEMA 18.22 · DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA (DDC GES N° 23)

ESQUEMA

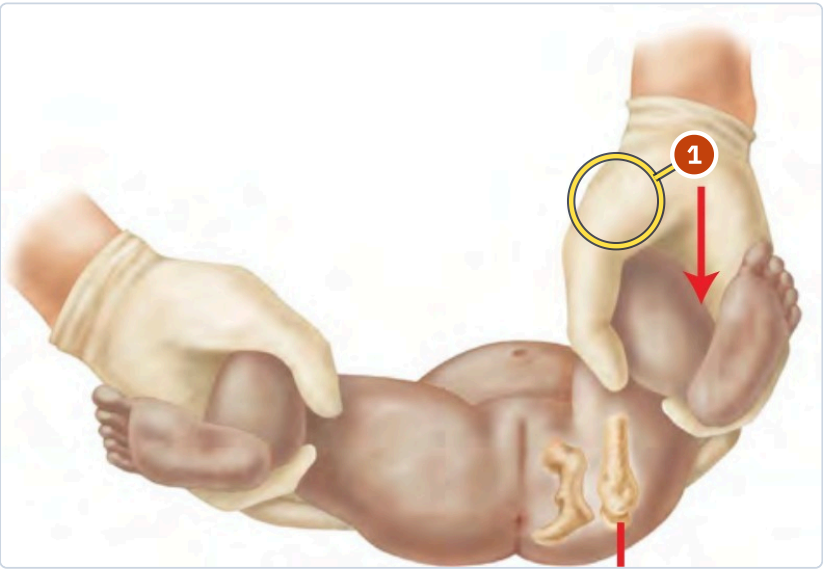


Imagen: Bates, Guía de exploración física 12.ª ed., Fig. 18-36

QUÉ TIENES QUE VER

1 Presión posterior

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Barlow

Luxa la cadera inestable.

CONDUCTA INICIAL

Derivar a ortopedia.

2.01.1.092 **Displasia de caderas**

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ortolani: reduce.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 141** Tema 18.22

Clase 18.22 en video

67 TEMA 18.22 · DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA (DDC GES N° 23)

ECOGRAFÍA

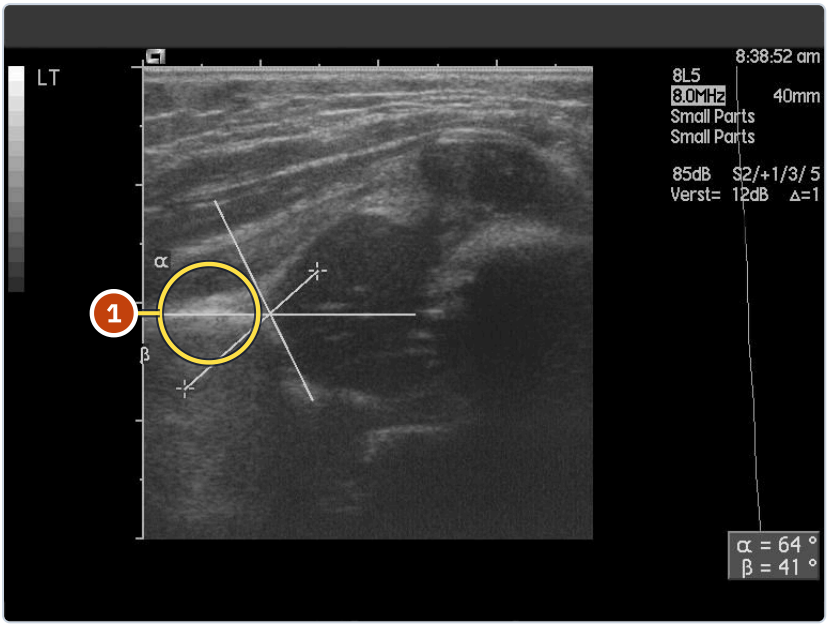


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 2.5

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ángulo α

DIAGNÓSTICO

Ecografía de cadera (Graf)

Ángulos α y β.

CONDUCTA INICIAL

α < 60°: displasia.

2.01.1.092 **Displasia de caderas**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.02.3.006 **Prevención de displasia de cadera (diagnóstico precoz)**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cadera inmadura.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 141** Tema 18.22

Clase 18.22 en video

68 TEMA 18.22 · DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA (DDC GES N° 23)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Arnés

DIAGNÓSTICO

Arnés de Pavlik

Caderas en flexión y abducción.

CONDUCTA INICIAL

Tratamiento de la displasia en menores de 6 meses.

4.02.1.002 **Displasia congénita de cadera**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Doble pañal: no sirve.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P137** «Un niño es diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante una radiografía, que muestra la displasia, con luxación del…» → **Correas de Pavlik**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA **p. 143** Tema 18.22

Clase 18.22 en video

69 TEMA 18.22 · DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA (DDC GES N° 23)

IMAGEN RADIOLÓGICA

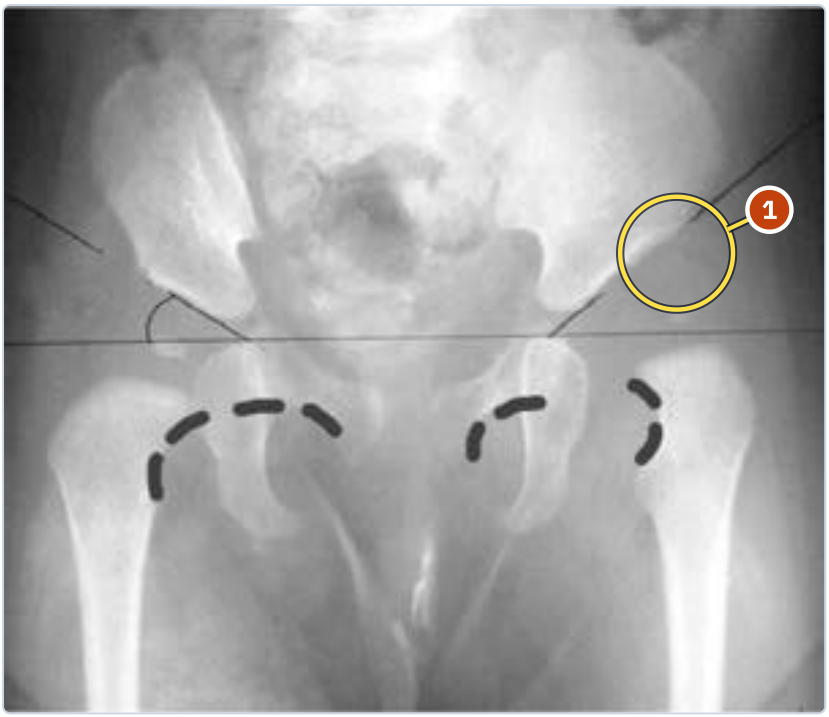


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 5432

QUÉ TIENES QUE VER

1 Acetábulo

DIAGNÓSTICO

Displasia de cadera en la Rx

Índice acetabular aumentado.

CONDUCTA INICIAL

Rx a los 3 meses (GES).

2.01.4.007	Radiografía de pelvis anteroposterior — examen/procedimiento
4.02.3.006	Prevención de displasia de cadera (diagnóstico precoz) — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cadera normal.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P34 «Niño de 3 meses con radiografía de pelvis con ángulos acetabulares bajo 30° bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?» → **Mantener controles habituales**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 140
Tema 18.22

Clase 18.22 en video

70 TEMA 18.22 · DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA (DDC GES N° 23)

IMAGEN RADIOLÓGICA

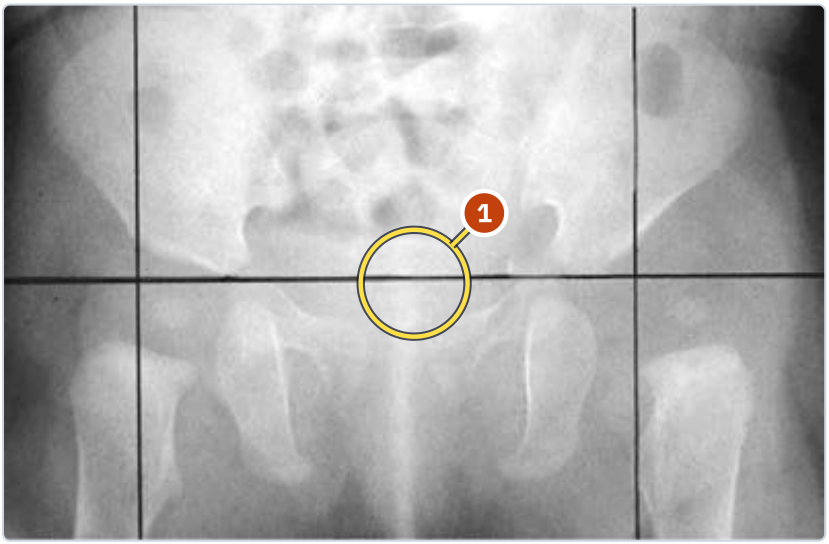


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 5432

QUÉ TIENES QUE VER

1 Línea de Hilgenreiner

DIAGNÓSTICO

Rx de pelvis con líneas de referencia

Hilgenreiner y Perkins.

CONDUCTA INICIAL

La cabeza debe estar en el cuadrante inferointerno.

2.01.1.092	Displasia de caderas — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Lectura sin líneas.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P34 «Una lactante de 2 meses, alimentada con lactancia materna exclusiva y con adecuado incremento ponderal, presenta en su examen físico signo de…» → **Solicitar ecogra:a de caderas**

TOMO PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
p. 140
Tema 18.22

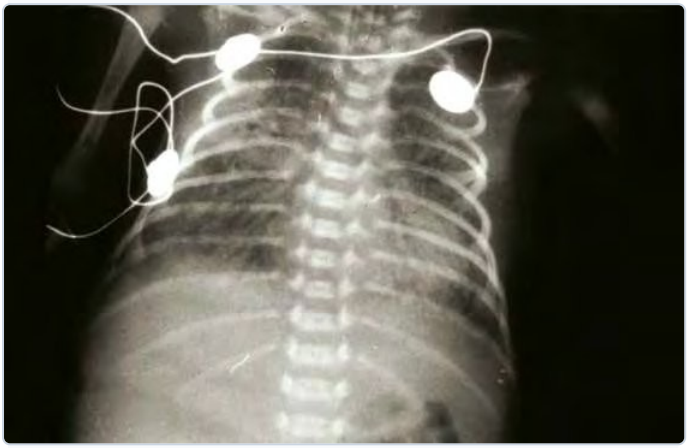
Clase 18.22 en video

Parecidas pero distintas

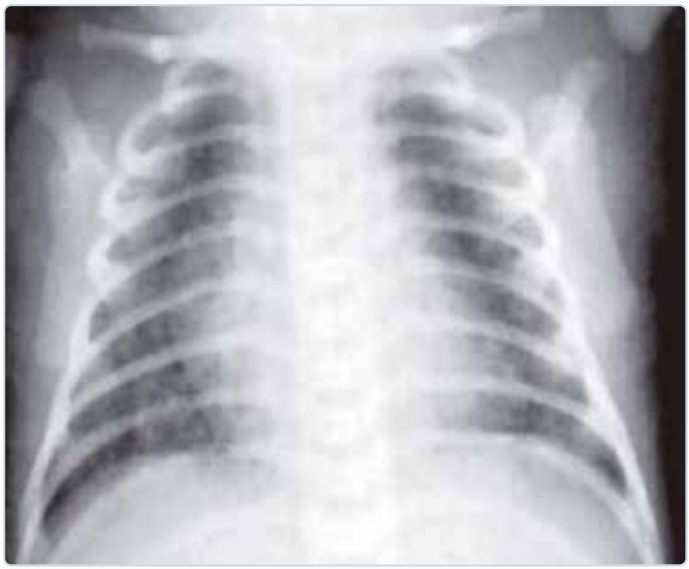
Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Membrana hialina vs taquipnea transitoria



VS



A Enfermedad de membrana hialina

- Vidrio esmerilado

Ficha n.° 59 · p. 33

B Taquipnea transitoria

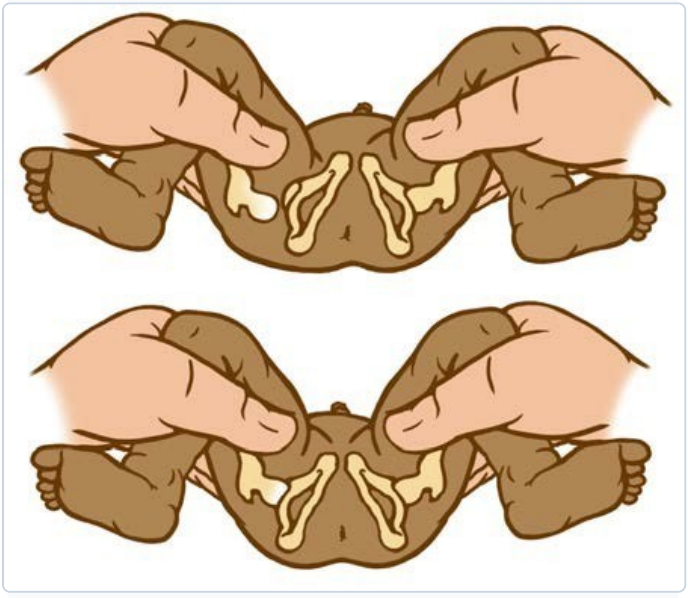
- Líquido en cisuras

Ficha n.° 60 · p. 33

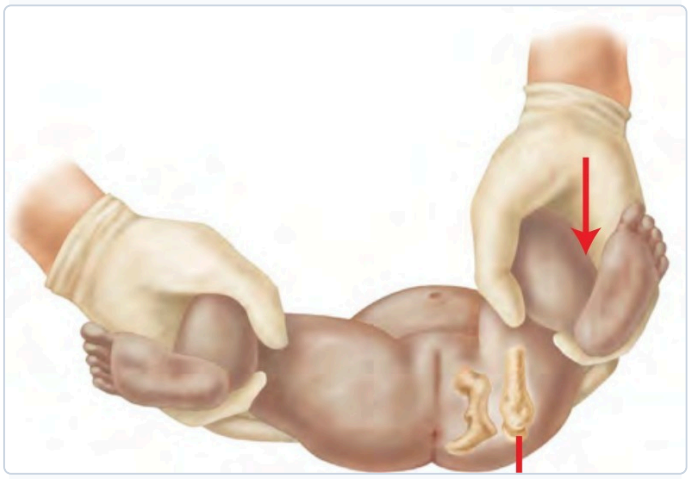
LA DIFERENCIA La EMH necesita surfactante.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Ortolani vs Barlow



VS



A Maniobra de Ortolani

- Reduce

Ficha n.° 65 · p. 36

B Maniobra de Barlow

- Luxa

Ficha n.° 66 · p. 36

LA DIFERENCIA Ambas buscan displasia.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Quemaduras por inmersión



VS



A Quemadura en calcetín

- Pie

Ficha n.° 13 · p. 10

B Quemadura en guante

- Mano

Ficha n.° 14 · p. 10

LA DIFERENCIA Bordes netos: maltrato.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



SIGNO DE CROWE

Pecas axilares.

Se ve en: Neurofibromatosis tipo 1.

Tomo p. 19 · Atlas: ficha n.° 07, p. 7



SIGNO DE LA BOFETADA

Mejillas rojas.

Se ve en: Eritema infeccioso.

Tomo p. 74 · Atlas: ficha n.° 36, p. 21



IMAGEN EN DIANA

Anillos concéntricos en la ecografía.

Se ve en: Invaginación intestinal.

Tomo p. 85 · Atlas: ficha n.° 45, p. 26

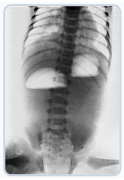


MANCHAS DE KOPLIK

Puntos blancos en la mucosa yugal.

Se ve en: Sarampión.

Tomo p. 77 · Atlas: ficha n.° 41, p. 24



DOBLE BURBUJA

Estómago y duodeno dilatados.

Se ve en: Atresia duodenal.

Tomo p. 85 · Atlas: ficha n.° 46, p. 26

Índice por tipo de imagen

25	13	20	4	4	2	2
FOTO CLÍNICA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	ECOGRAFÍA	ENDOSCOPÍA	FONDO DE OJO

Foto clínica · 25

04 Acople correcto (18.4) 5
06 Mancha mongólica (18.4) 6
07 Signo de Crowe (18.4) 7
08 Vitíligo (18.4) 7
09 Facies del síndrome de Down (18.26) 8
10 Manchas de Brushfield (18.26) 8
11 Piel laxa de la nuca (18.26) 9
12 Hipotonía en la suspensión ventral (18.26) 9
13 Quemadura en calcetín (18.28) 10
14 Quemadura en guante (18.28) 10
17 Dificultad respiratoria en la bronquiolitis (18.5) 12
35 Exantema súbito (18.10) 21
36 Eritema infeccioso: signo de la bofetada (18.10) 21
37 Lengua en fresa blanca (18.10) 22
38 Kawasaki: labios fisurados (18.10) 22
39 Escarlatina (18.10) 23
40 Rubéola congénita: cataratas (18.10) 23
41 Manchas de Koplik (18.10) 24
42 Signo del pliegue (18.11) 24
44 Deposición en jalea de grosella (18.12) 25
52 Eccema en Wiskott-Aldrich (18.25) 29
53 Compresiones torácicas neonatales (18.15) 30
57 Ictericia neonatal (18.17) 32
62 Hipotiroidismo congénito sin tratar (18.21) 34
68 Arnés de Pavlik (18.22) 37

Esquema · 13

01 Curva de peso para la edad (OMS) (18.1) 4
02 Hitos del desarrollo psicomotor (18.2) 4
03 Acople incorrecto vs correcto (18.4) 5
05 Succión efectiva (18.4) 6
27 Desobstrucción en el lactante (18.8) 17
28 Maniobra de Heimlich (18.8) 17
49 Grados de reflujo vesicoureteral (18.13) 28
55 Test de Capurro (18.16) 31
58 Nomograma de Bhutani y zonas de Kramer (18.17) 32
63 Zonas de punción del talón (18.21) 35
64 Tarjeta de papel filtro (18.21) 35
65 Maniobra de Ortolani (18.22) 36
66 Maniobra de Barlow (18.22) 36

Imagen radiológica · 20

15 Fracturas sugerentes de maltrato (18.28) 11
18 Bronquiolitis: hiperinsuflación (18.5) 12
19 Signo del campanario (18.6) 13
21 Signo del pulgar (18.6) 14
22 Neumonía lobar (18.7) 14
23 Neumonía redonda (18.7) 15
24 Infiltrado intersticial (18.7) 15
25 Consolidación con broncograma (18.7) 16
26 Cuerpo extraño en el bronquio derecho (18.8) 16
46 Doble burbuja (18.12) 26
47 Doble burbuja neonatal (18.12) 27
48 Invaginación: signo del menisco (18.12) 27
50 Reflujo vesicoureteral de alto grado (18.13) 28
51 DMSA con cicatriz cortical (18.13) 29
54 Atresia de coanas (18.15) 30
59 Enfermedad de membrana hialina (18.18) 33
60 Taquipnea transitoria (18.18) 33
61 Aspiración meconial (18.18) 34
69 Displasia de cadera en la Rx (18.22) 38
70 Rx de pelvis con líneas de referencia (18.22) 38

Trazado (ECG / registro) · 4

29 Taquicardia supraventricular (18.23) 18
30 Preexcitación (WPW) (18.23) 18
32 ECG normal de un recién nacido (18.23) 19
33 ECG normal de un niño de 3 años (18.23) 20

Ecografía · 4

31 Vegetaciones en la ecografía (18.23) 19
43 Estenosis hipertrófica del píloro (18.12) 25
45 Imagen en diana (18.12) 26
67 Ecografía de cadera (Graf) (18.22) 37

Endoscopía · 2

20 Epiglotis rojo cereza (18.6) 13
34 Lesión esofágica grave por cáusticos (18.24) 20

Fondo de ojo · 2

16 Hemorragias retinianas en el niño sacudido (18.28) 11
56 Retinopatía del prematuro tratada (18.16) 31

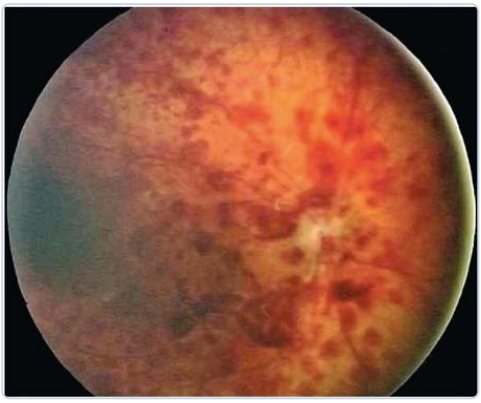
Autoevaluación

6 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



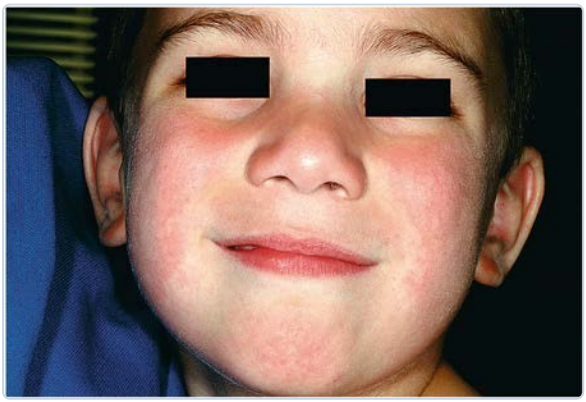
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Quemadura en calcetín**	Borde neto	13 · p. 10
2	**Hemorragias retinianas en el niño sacudido**	Hemorragias	16 · p. 11
3	**Signo del campanario**	Subglotis estrecha	19 · p. 13
4	**Exantema súbito**	Exantema	35 · p. 21
5	**Eritema infeccioso: signo de la bofetada**	Mejilla roja	36 · p. 21
6	**Ictericia neonatal**	Cara amarilla	57 · p. 32